ΚΥΡΙΟ ΥΛΙΚΟ

Πρωτόκολλο Εφημερίας: 50 Επείγοντα Σενάρια

Για 50 επείγουσες κλινικές εικόνες που συναντάτε στην εφημερία, βρείτε σε μία σελίδα ποια εξέταση θα προτείνετε, με ποια σειρά θα διαβάσετε την εικόνα, ποια κόκκινη σημαία θα αναζητήσετε και πότε και πώς θα τηλεφωνήσετε στον επιμελητή σας.

Περιεχόμενα

Πώς χρησιμοποιείται αυτό το πρωτόκολλο

Ενότητα 1 · Επείγοντα νευροακτινολογίας (Σενάρια 1–12)

Ενότητα 2 · Επείγοντα θώρακα (Σενάρια 13–22)

Ενότητα 3 · Επείγοντα κοιλίας και πυέλου (Σενάρια 23–36)

Ενότητα 4 · Τραύμα (Σενάρια 37–44)

Ενότητα 5 · Παιδιατρική και κύηση (Σενάρια 45–50)

Επόμενο βήμα

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Πώς χρησιμοποιείται αυτό το πρωτόκολλο

50 σενάρια, το καθένα με τις ίδιες έξι επικεφαλίδες: κλινική εικόνα, επιλογή εξέτασης, σειρά ανάγνωσης, κόκκινες σημαίες, πότε να τηλεφωνήσετε και τι γράφεται στη γνωμάτευση.

> *Η πιο δύσκολη στιγμή στην εφημερία είναι όταν έχετε μια εικόνα στην οθόνη και μια ερώτηση στο μυαλό σας και κανέναν δίπλα σας. Αυτό το πρωτόκολλο γράφτηκε για εκείνη τη στιγμή: να ξέρετε τι θα κάνετε, να ξέρετε ποιον θα καλέσετε και πότε.*

Οι ίδιες έξι επικεφαλίδες σε κάθε σενάριο

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ	ΤΙ ΣΑΣ ΛΕΕΙ
Κλινική εικόνα	Σε ποιον ασθενή πρέπει να σκεφτείτε αυτό το σενάριο.
Ποια εξέταση;	Η πρώτη εξέταση και η αιτία· σε ποια περίπτωση προηγείται το υπερηχογράφημα, η αξονική ή η μαγνητική.
Σειρά ανάγνωσης	Αριθμημένα βήματα, ώστε να διαβάζετε την εικόνα κάθε φορά με την ίδια σειρά.
Κόκκινες σημαίες	Ευρήματα που κάνουν την κατάσταση επείγουσα τη στιγμή που τα βλέπετε.
Πότε πρέπει να τηλεφωνήσετε στον επιμελητή σας	Καταστάσεις στις οποίες πρέπει να τηλεφωνήσετε χωρίς αναμονή.
Γράψτε οπωσδήποτε στη γνωμάτευση	Διατυπώσεις που δεν πρέπει να λείπουν από τη γνωμάτευση.

Μέθοδος 4 βημάτων σε κάθε ανάγνωση

1. **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ** — Ταυτοποιήστε (σωστός ασθενής, σωστή εξέταση, ημερομηνία, πρωτόκολλο), ελέγξτε την ποιότητα (τεχνική επάρκεια), προσανατολιστείτε (πλευρά, τομή, παράθυρο ή ακολουθία).

2. **ΣΑΡΩΣΤΕ** — Σαρώστε κάθε περιοχή κάθε φορά με την ίδια σειρά. Μη σταματάτε στο πρώτο εύρημα.

3 **ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ** — Περιγράψτε με τους σωστούς όρους (πυκνότητα, σήμα, ηχογένεια), εντόπιση, μέγεθος και όρια· συγκρίνετε με την προηγούμενη εξέταση και με την αντίθετη πλευρά.

4 **ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ** — Συμπέρασμα γνωμάτευσης, διαφορική διάγνωση, σύσταση. Ενημερώστε τον κλινικό ιατρό για το επείγον εύρημα και καταγράψτε την ενημέρωση.

Το πρωτόκολλο του ιδρύματος έχει πάντα προτεραιότητα

Οι επιλογές εξετάσεων σε αυτό το υλικό είναι γενικές προσεγγίσεις. Το πρωτόκολλο του νοσοκομείου όπου εργάζεστε, η καθοδήγηση του επιμελητή σας και η κλινική κατάσταση του ασθενούς έχουν πάντα προτεραιότητα. Σε κάθε περίπτωση που δεν είστε βέβαιοι, η ερώτηση δεν είναι αδυναμία, αλλά ασφάλεια του ασθενούς.

Το όριό σας για να τηλεφωνήσετε να είναι χαμηλό

Ως ειδικευόμενος 1ου έτους, η ανησυχία «θα ενοχλήσω άσκοπα τον επιμελητή μου» είναι φυσιολογική. Οι επικεφαλίδες «Πότε πρέπει να τηλεφωνήσετε στον επιμελητή σας» σε αυτό το πρωτόκολλο ξεκαθαρίζουν τις στιγμές στις οποίες πρέπει να τηλεφωνήσετε χωρίς αναμονή. Τι πρέπει να έχετε έτοιμο πριν τηλεφωνήσετε θα το βρείτε στο Μπόνους 1.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Επείγοντα νευροακτινολογίας

Σενάρια 1–12 · Αιμορραγία, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ενδοκράνια πίεση, λοίμωξη και επείγοντα σπονδυλικής στήλης.

Σενάριο 01 ΝΕΥΡΟ

Αιφνίδια, η πιο έντονη κεφαλαλγία της ζωής του

Κλινική εικόνα: Κεφαλαλγία που κορυφώνεται μέσα σε δευτερόλεπτα· μπορεί να συνοδεύεται από ναυτία, αυχενική δυσκαμψία ή σύντομη απώλεια συνείδησης. Πρέπει να αποκλειστεί η υπαραχνοειδής αιμορραγία (ΥΑΑ).

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Η αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό είναι η πρώτη εξέταση: είναι γρήγορη και δείχνει την οξεία αιμορραγία ως υπέρπυκνη. Αν φανεί ΥΑΑ, η αξονική αγγειογραφία για αναζήτηση ανευρύσματος σχεδιάζεται μαζί με την κλινική ομάδα και τον επιμελητή σας. Αν η αξονική είναι αρνητική αλλά η υποψία επιμένει, το επόμενο βήμα (οσφυονωτιαία παρακέντηση ή περαιτέρω απεικόνιση) καθορίζεται με την κλινική ομάδα.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Βασικές δεξαμενές: υπερεφιππιακή, περιμεσεγκεφαλική, μεσοσκελιδική. Φυσιολογικά είναι μαύρες και συμμετρικές.
2. Σχισμές του Sylvius και μεσοημισφαιρική σχισμή.
3. Ινιακά κέρατα των πλάγιων κοιλιών: ιζηματοποιημένο αίμα.
4. Φλοιώδεις αύλακες έως την κορυφή.
5. Μέγεθος των κοιλιών και κροταφικά κέρατα: πρώιμος υδροκέφαλος.
6. Παρεγχυματικό αιμάτωμα, πιεστική επίδραση, μέση γραμμή.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Οξύς υδροκέφαλος · ενδοκοιλιακό αίμα · ενδοπαρεγχυματικό αιμάτωμα · σημεία εγκεφαλικού εγκολεασμού

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Τη στιγμή που υποψιάζεστε ΥΑΑ. Συζητήστε επίσης αν η εικόνα είναι αρνητική αλλά η κλινική υποψία είναι πολύ υψηλή.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Κατανομή του αίματος (δεξαμενές, σχισμές, κοιλίες), υδροκέφαλος ναι/όχι, πιεστική επίδραση, σύσταση αξονικής αγγειογραφίας, σε ποιον και πότε έγινε η ενημέρωση.

Σενάριο 02 ΝΕΥΡΟ

Υποψία οξέος αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου: κωδικός εγκεφαλικού

Κλινική εικόνα: Αιφνίδια ασυμμετρία προσώπου, αδυναμία χεριού ή ποδιού, διαταραχή λόγου. Ο χρόνος έναρξης των συμπτωμάτων είναι γνωστός· ο ασθενής μπορεί να είναι υποψήφιος για οξεία θεραπεία.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Πρώτα η αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό: ο αποκλεισμός αιμορραγίας είναι η πρώτη προϋπόθεση για την απόφαση θεραπείας. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος προστίθεται αξονική αγγειογραφία (απόφραξη μεγάλου αγγείου) και, αν χρειάζεται, αιμάτωση. Η μαγνητική (DWI) χρησιμοποιείται σε ορισμένα κέντρα σε επιλεγμένους ασθενείς· δεν πρέπει να προκαλεί απώλεια χρόνου.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Πρώτα η αιμορραγία: παρέγχυμα, εξωαξονικοί χώροι, κοιλίες.
2. Υπέρπυκνη αρτηρία: MCA, βασική αρτηρία.
3. Πρώιμη ισχαιμία: εξάλειψη της νησιωτικής ταινίας, του ορίου του φακοειδούς πυρήνα και της διάκρισης φαιάς-λευκής ουσίας (στενό παράθυρο εγκεφαλικού).
4. Μάζα, όγκος ή άλλη αιτία που μιμείται αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.
5. Αν υπάρχει αξονική αγγειογραφία: πρώτα τα μεγάλα ενδοκράνια αγγεία, μετά τα αγγεία του τραχήλου και το τόξο.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Οποιαδήποτε αιμορραγία · απόφραξη μεγάλου αγγείου · πρώιμη ισχαιμία σε εκτεταμένη περιοχή · συμμετοχή της οπίσθιας κυκλοφορίας

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Όταν ενεργοποιείται ο κωδικός εγκεφαλικού, ενημερώστε χωρίς να περιμένετε την ανάγνωση. Όταν βλέπετε αιμορραγία, απόφραξη ή πρώιμη ισχαιμία για την οποία δεν είστε βέβαιοι, τηλεφωνήστε αμέσως.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Αιμορραγία ναι/όχι (πρώτη πρόταση), υπέρπυκνη αρτηρία, θέση των πρώιμων ισχαιμικών αλλοιώσεων, επίπεδο της απόφραξης (αν υπάρχει αξονική αγγειογραφία), ώρα ενημέρωσης.

Σενάριο 03 ΝΕΥΡΟ

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο που διαπιστώθηκε κατά την αφύπνιση: άγνωστος χρόνος έναρξης

Κλινική εικόνα: Ο ασθενής ξύπνησε το πρωί με έλλειμμα ή δεν είναι γνωστό πότε θεωρήθηκε τελευταία φορά φυσιολογικός.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Και πάλι ξεκινά κανείς με αξονική χωρίς σκιαγραφικό για να αποκλείσει αιμορραγία. Σε ασθενή με άγνωστο χρόνο έναρξης, για επιλογή με βάση τον ιστό, μπορεί να ζητηθεί μαγνητική (DWI και FLAIR) ή αξονική αιμάτωσης σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος. Ποια οδός θα ακολουθηθεί αποφασίζουν από κοινού η νευρολογική ομάδα και ο επιμελητής σας.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Αποκλεισμός αιμορραγίας (σειρά του Σεναρίου 02).
2. Σαφής υπόπυκνη περιοχή στην αξονική: υποδηλώνει εγκατεστημένο έμφρακτο.
3. Αν υπάρχει μαγνητική: περιοχή περιορισμού της διάχυσης στην DWI και αντιστοιχία στον ADC.
4. Η εικόνα FLAIR της ίδιας περιοχής: σημειώστε την αντιστοιχία DWI και FLAIR.
5. Επίπεδο της απόφραξης, αν υπάρχει αγγειακή απεικόνιση.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Εκτεταμένο έμφρακτο και πιεστική επίδραση · διόγκωση στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο και πίεση της τέταρτης κοιλίας · αιμορραγική μετατροπή

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Πριν ξεκαθαρίσει η επιλογή εξέτασης και σε κάθε περίπτωση που δεν είστε βέβαιοι για την ερμηνεία της αντιστοιχίας DWI/FLAIR.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Αιμορραγία ναι/όχι, θέση και έκταση του εμφράκτου, σχέση DWI και FLAIR, πιεστική επίδραση, αγγειακό εύρημα.

Σενάριο 04 ΝΕΥΡΟ

Θόλωση συνείδησης σε ηλικιωμένο ασθενή: υποψία υποσκληρίδιου αιματώματος

Κλινική εικόνα: Ηλικιωμένος ασθενής υπό αντιπηκτική ή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή· σύγχυση που επιδεινώνεται μέσα σε ημέρες, με ή χωρίς ιστορικό πτώσης.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό. Το υποξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα μπορεί να είναι ισόπυκνο με τον εγκέφαλο· σε αυτή την περίπτωση βασίζεστε στα έμμεσα ευρήματα. Η μαγνητική μπορεί να σχεδιαστεί αργότερα σε αμφίβολα περιστατικά· δεν είναι το πρώτο βήμα στα επείγοντα.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Συγκρίνετε τις κυρτότητες αμφοτερόπλευρα: μηνοειδής συλλογή σε επαφή με τον θόλο του κρανίου.
2. Λεπτή υπέρπυκνη στιβάδα κατά μήκος του δρεπάνου και του σκηνιδίου.
3. Επανεξετάστε την περιοχή δίπλα στο κρανιακό θόλο με ευρύ παράθυρο (υποσκληρίδιο παράθυρο).
4. Εξάλειψη των αυλάκων στη μία πλευρά, πίεση των κοιλιών, μετατόπιση της μέσης γραμμής.
5. Μικτή πυκνότητα: οξεία αιμορραγία σε χρόνιο υπόστρωμα.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Μετατόπιση της μέσης γραμμής · εξάλειψη των βασικών δεξαμενών · αμφοτερόπλευρη συλλογή (πίεση χωρίς μετατόπιση) · νέα αιμορραγία εντός της συλλογής

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Σε κάθε υποσκληρίδιο αιμάτωμα με πιεστική επίδραση και όταν υποψιάζεστε ισόπυκνη συλλογή αλλά δεν είστε βέβαιοι.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Πλευρά, έκταση, πυκνότητα (οξύ / υποξύ / χρόνιο / μικτό), πάχος στο παχύτερο σημείο, μετατόπιση της μέσης γραμμής, σημεία εγκεφαλικού εγκολεασμού, μεταβολή αν έγινε σύγκριση.

Σενάριο 05 ΝΕΥΡΟ

Αιφνίδιο έλλειμμα σε υπερτασικό ασθενή: ενδοεγκεφαλική αιμορραγία

Κλινική εικόνα: Αιφνίδια ημιπάρεση, κεφαλαλγία, έμετος, ταχεία επιδείνωση του επιπέδου συνείδησης· συχνά υψηλή αρτηριακή πίεση.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό. Αν η θέση του αιματώματος δεν είναι τυπική, αν ο ασθενής είναι νέος ή υπάρχει υποψία υποκείμενης αγγειακής βλάβης, μπορεί να συσταθεί αξονική αγγειογραφία· την απόφαση παίρνετε με τον επιμελητή σας και την κλινική ομάδα.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Θέση του αιματώματος: βασικά γάγγλια, θάλαμος, λοβός, εγκεφαλικό στέλεχος, παρεγκεφαλίδα.
2. Μέτρηση σε τρία επίπεδα για τον όγκο.
3. Διάνοιξη στις κοιλίες και υδροκέφαλος.
4. Περιβάλλον οίδημα, πιεστική επίδραση, μετατόπιση της μέσης γραμμής, εγκεφαλικός εγκολεασμός.
5. Άτυπα χαρακτηριστικά: λοβιακή εντόπιση, επίπεδο υγρού-υγρού, εικόνα υποκείμενης μάζας.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Παρεγκεφαλιδικό αιμάτωμα · επέκταση στις κοιλίες και υδροκέφαλος · εγκεφαλικός εγκολεασμός · χρήση αντιπηκτικών

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Σε κάθε νέο ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα· ιδιαίτερα σε εντόπιση στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο και παρουσία υδροκεφάλου, χωρίς αναμονή.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Θέση, μετρήσεις σε τρεις διαστάσεις, διάνοιξη στις κοιλίες, υδροκέφαλος, πιεστική επίδραση, μετατόπιση της μέσης γραμμής, σύσταση συμπληρωματικής εξέτασης.

Σενάριο 06 ΝΕΥΡΟ

Γνωστή μάζα, κεφαλαλγία και έμετοι: κίνδυνος εγκεφαλικού εγκολεασμού

Κλινική εικόνα: Επιδεινούμενη κεφαλαλγία, έμετοι, έκπτωση του επιπέδου συνείδησης σε ασθενή με γνωστό όγκο ή μετάσταση εγκεφάλου.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Στα επείγοντα, η αξονική χωρίς σκιαγραφικό δείχνει γρήγορα την πιεστική επίδραση, την αιμορραγία και τον υδροκέφαλο. Η μαγνητική με σκιαγραφικό έχει μεγαλύτερη αξία για τον χαρακτηρισμό της βλάβης, αλλά πρέπει να περιμένει αν ο ασθενής δεν είναι σταθερός.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Βλάβη και περιβάλλον αγγειογενές οίδημα.
2. Αιμορραγία εντός της βλάβης.
3. Μετατόπιση της μέσης γραμμής και υποδρεπανικός εγκολεασμός.
4. Εγκολεασμός του άγκιστρου: ασυμμετρία της υπερεφιππιακής δεξαμενής, έσω χείλος του κροταφικού λοβού.
5. Επίπεδο των παρεγκεφαλιδικών αμυγδαλών και τέταρτη κοιλία.
6. Αποφρακτικού τύπου υδροκέφαλος στις κοιλίες.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Οποιοδήποτε σημείο εγκεφαλικού εγκολεασμού · νέα αιμορραγία · αποφρακτικός υδροκέφαλος

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Τη στιγμή που βλέπετε αύξηση της πιεστικής επίδρασης σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση, εγκεφαλικό εγκολεασμό ή υδροκέφαλο.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση (ημερομηνία), μεταβολή του οιδήματος και της μετατόπισης, τύπος εγκεφαλικού εγκολεασμού, υδροκέφαλος, αιμορραγία.

Σενάριο 07 ΝΕΥΡΟ

Ασθενής με κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση: δυσλειτουργία της παροχέτευσης

Κλινική εικόνα: Κεφαλαλγία, έμετος, υπνηλία σε ασθενή με παροχέτευση· στα παιδιά ανησυχία και διαταραχή σίτισης.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό (στα παιδιά μπορεί να υπάρχει πρωτόκολλο χαμηλής δόσης ή ταχείας μαγνητικής του ιδρύματος) και σειρά απλών ακτινογραφιών που δείχνει τη διαδρομή της παροχέτευσης. Το πιο πολύτιμο εργαλείο είναι η σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Συγκρίνετε δίπλα-δίπλα το μέγεθος των κοιλιών με την προηγούμενη εξέταση.
2. Κροταφικά κέρατα και τρίτη κοιλία.
3. Περικοιλιακή υπόπυκνη περιοχή: διεπενδυμική ροή.
4. Θέση του άκρου του καθετήρα.
5. Στη σειρά ακτινογραφιών της παροχέτευσης, διακοπή, αναδίπλωση, μετατόπιση κατά μήκος της διαδρομής.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Αύξηση του μεγέθους των κοιλιών · διεπενδυμικό οίδημα · διακοπή της διαδρομής της παροχέτευσης · νέα αιμορραγία

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Όταν βλέπετε αύξηση του μεγέθους των κοιλιών ή διαταραχή της ακεραιότητας της διαδρομής. Τηλεφωνήστε και όταν δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση και δεν μπορείτε να αποφασίσετε.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Ημερομηνία της εξέτασης σύγκρισης, μεταβολή στο μέγεθος των κοιλιών, άκρο του καθετήρα, ακεραιότητα της διαδρομής της παροχέτευσης (shunt).

Σενάριο 08 ΝΕΥΡΟ

Πυρετός, κεφαλαλγία, αυχενική δυσκαμψία: αξονική πριν από την οσφυονωτιαία παρακέντηση

Κλινική εικόνα: Υποψία μηνιγγίτιδας ή εγκεφαλίτιδας· η κλινική ομάδα έχει ζητήσει απεικόνιση πριν από την οσφυονωτιαία παρακέντηση.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό: αναζητά πιεστική επίδραση, αιμορραγία και υδροκέφαλο, που θα μπορούσαν να κάνουν την οσφυονωτιαία παρακέντηση επικίνδυνη. Σε υποψία εγκεφαλίτιδας, αποστήματος ή επιπλοκής η μαγνητική με σκιαγραφικό είναι πιο ευαίσθητη· τον χρόνο τον καθορίζει η κλινική ομάδα.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Πιεστική επίδραση, μέση γραμμή, βασικές δεξαμενές.
2. Υδροκέφαλος.
3. Υπόπυκνη περιοχή στους κροταφικούς λοβούς (μπορεί να είναι υπέρ εγκεφαλίτιδας).
4. Απόστημα ή εμπύημα: εξωαξονική συλλογή.
5. Παραρρίνιοι κόλποι και μαστοειδείς αποφύσεις στο οστικό παράθυρο: αναζήτηση της πηγής.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Πιεστική επίδραση ή εγκεφαλικός εγκολεασμός (ενημερώστε οπωσδήποτε πριν από την οσφυονωτιαία παρακέντηση) · υποσκληρίδιο εμπύημα · απόστημα · υδροκέφαλος

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Σε κάθε εύρημα που μπορεί να επηρεάσει την οσφυονωτιαία παρακέντηση και όταν υποψιάζεστε εγκεφαλίτιδα, για το σχέδιο της μαγνητικής.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Ρητά η πρόταση «πιεστική επίδραση, σημείο εγκεφαλικού εγκολεασμού, υδροκέφαλος που θα μπορούσαν να αντενδείκνυνται την οσφυονωτιαία παρακέντηση» ναι/όχι· κατάσταση παραρρίνιων κόλπων και μαστοειδών· σύσταση μαγνητικής αν χρειάζεται.

Σενάριο 09 ΝΕΥΡΟ

Ενήλικας με πρώτη επιληπτική κρίση

Κλινική εικόνα: Γενικευμένη ή εστιακή κρίση σε ενήλικα χωρίς προηγούμενο ιστορικό κρίσεων· η ταχύτητα ανάκαμψης μετά την κρίση ποικίλλει.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Στα επείγοντα, η αξονική χωρίς σκιαγραφικό αποκλείει γρήγορα αιμορραγία, μάζα και τραύμα. Για λεπτομερή εκτίμηση της επιληψίας η μαγνητική έχει μεγαλύτερη αξία και συχνά προγραμματίζεται τακτικά. Αν το εστιακό έλλειμμα επιμένει, σκεφτείτε το πρωτόκολλο αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Αιμορραγία και θλάση (πτώση κατά την κρίση).
2. Μάζα, οίδημα, αποτιτάνωση.
3. Ιππόκαμπος και κροταφικοί λοβοί.
4. Φλοιώδης υπόπυκνη περιοχή: έμφρακτο ή φλεβικό έμφρακτο.
5. Κάταγμα του θόλου του κρανίου στο οστικό παράθυρο.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Αιμορραγία · μάζα και οίδημα · ισχαιμία συμβατή με επίμονο εστιακό έλλειμμα · ευρήματα που υποδηλώνουν φλεβική θρόμβωση

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Σε υποψία νέας μάζας, αιμορραγίας ή θρόμβωσης φλεβωδών κόλπων.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Οξεία παθολογία ναι/όχι, τραυματικό εύρημα, σύσταση μαγνητικής (μαζί με την ένδειξη).

Σενάριο 10 ΝΕΥΡΟ

Αιφνίδιος ίλιγγος, αταξία, διπλωπία: οπίσθια κυκλοφορία

Κλινική εικόνα: Ίλιγγος, αδυναμία βάδισης, δυσαρθρία, διπλωπία ή μεταβολή του επιπέδου συνείδησης· η εικόνα μερικές φορές συγχέεται με περιφερικό ίλιγγο.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Η αξονική χωρίς σκιαγραφικό αποκλείει την αιμορραγία, αλλά δεν είναι ευαίσθητη στην πρώιμη ισχαιμία του οπίσθιου κρανιακού βόθρου· τα οστικά τεχνικά σφάλματα δυσχεραίνουν την εκτίμηση. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος σχεδιάζεται αξονική αγγειογραφία (βασική και σπονδυλικές αρτηρίες) και μαγνητική (DWI).

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Παρεγκεφαλίδα και εγκεφαλικό στέλεχος: αιμορραγία, υπόπυκνη περιοχή.
2. Υπέρπυκνη βασική αρτηρία.
3. Πίεση της τέταρτης κοιλίας και υδροκέφαλος.
4. Συνέχεια της βασικής και των σπονδυλικών αρτηριών στην αξονική αγγειογραφία.
5. Αν υπάρχει μαγνητική, περιορισμός της διάχυσης στην DWI στην παρεγκεφαλίδα και στο εγκεφαλικό στέλεχος.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Απόφραξη της βασικής αρτηρίας · διόγκωση παρεγκεφαλιδικού εμφράκτου · πίεση της τέταρτης κοιλίας · υδροκέφαλος

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Χωρίς αναμονή σε υποψία απόφραξης της βασικής αρτηρίας. Αν η αξονική είναι φυσιολογική αλλά η κλινική εικόνα παραπέμπει σε οπίσθια κυκλοφορία, για το σχέδιο περαιτέρω διερεύνησης.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Πρόταση που αναφέρει την περιορισμένη ευαισθησία της αξονικής στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο, αγγειακά ευρήματα, πιεστική επίδραση, σύσταση μαγνητικής.

Σενάριο 11 ΝΕΥΡΟ

Προοδευτικά επιδεινούμενη κεφαλαλγία: θρόμβωση εγκεφαλικών φλεβωδών κόλπων

Κλινική εικόνα: Κεφαλαλγία που επιδεινώνεται μέσα σε ημέρες, έμετος, θάμβος όρασης, κρίση ή εστιακό έλλειμμα· καταστάσεις κινδύνου όπως λοχεία, από του στόματος αντισύλληψη, αφυδάτωση.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Η αξονική χωρίς σκιαγραφικό είναι το πρώτο βήμα, αλλά μπορεί να είναι φυσιολογική. Αν η υποψία επιμένει, ζητείται αξονική ή μαγνητική φλεβογραφία σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Φλεβώδεις κόλποι της σκληράς μήνιγγας και φλοιώδεις φλέβες: αγγείο πιο υπέρπυκνο από το αναμενόμενο.
2. Υπόπυκνη περιοχή ή αιμορραγία που δεν αντιστοιχεί σε αρτηριακή περιοχή (φλεβικό έμφρακτο).
3. Αμφοτερόπλευρη, παραοβελιαία ή θαλαμική συμμετοχή.
4. Έλλειμμα πλήρωσης εντός του κόλπου στην εξέταση με σκιαγραφικό.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Φλεβικό έμφρακτο και αιμορραγία · συμμετοχή του εν τω βάθει φλεβικού συστήματος · πιεστική επίδραση

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Όταν υποψιάζεστε θρόμβωση φλεβωδών κόλπων, για να αποφασιστεί το πρωτόκολλο της φλεβογραφίας.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Προσβεβλημένοι κόλποι, παρεγχυματικά ευρήματα, αιμορραγία, σύσταση φλεβογραφίας.

Σενάριο 12 ΝΕΥΡΟ · ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Οσφυαλγία, αδυναμία των κάτω άκρων, επίσχεση ούρων

Κλινική εικόνα: Υποψία πίεσης του νωτιαίου μυελού ή συνδρόμου ιππουρίδας· μπορεί να υπάρχει ιστορικό γνωστής κακοήθειας, λοίμωξης ή τραύματος.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Η μαγνητική είναι η εξέταση επιλογής: ο νωτιαίος μυελός, η ιππουρίδα, ο δίσκος, ο επισκληρίδιος χώρος και ο μυελός των οστών φαίνονται σε μία εξέταση. Σε ιστορικό κακοήθειας μπορεί να σαρωθεί όλη η σπονδυλική στήλη σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος. Αν η μαγνητική δεν είναι εφικτή, η εναλλακτική οδός καθορίζεται με τον επιμελητή σας και την κλινική ομάδα.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Γενική σάρωση όλης της στήλης στην οβελιαία T2: επίπεδο του νωτιαίου μυελού ή της ιππουρίδας.
2. Μυελός των οστών στην οβελιαία T1: μετάσταση, κάταγμα.
3. Επισκληρίδιος χώρος: μάζα, απόστημα, αιμάτωμα, μεγάλος δίσκος.
4. Επιβεβαιώστε το επίπεδο της πίεσης στις αξονικές τομές.
5. Αύξηση του σήματος T2 στον νωτιαίο μυελό.
6. Αν υπάρχει σειρά με σκιαγραφικό, επισκληρίδιο απόστημα και περιφερική ενίσχυση.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Πίεση του νωτιαίου μυελού ή της ιππουρίδας · επισκληρίδιο απόστημα · συμμετοχή σε περισσότερα από ένα επίπεδα · παθολογικό κάταγμα

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Όταν έρθει το παραπεμπτικό για μαγνητική, για το πρωτόκολλο, και τη στιγμή που βλέπετε πίεση, πριν ολοκληρώσετε τη γνωμάτευση.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Επίπεδο και αιτία της πίεσης, σήμα του νωτιαίου μυελού, άλλο επίπεδο σε όλη τη σπονδυλική στήλη ναι/όχι, ώρα ενημέρωσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Επείγοντα θώρακα

Σενάρια 13–22 · Εμβολή, αορτή, πνευμοθώρακας, σωλήνες, αναπνευστική ανεπάρκεια.

Σενάριο 13 ΘΩΡΑΚΑΣ

Αιφνίδια δύσπνοια και πλευριτικός πόνος: υποψία πνευμονικής εμβολής

Κλινική εικόνα: Αιφνίδια δύσπνοια, ταχυκαρδία, θωρακικός πόνος, υποξία· ιστορικό ακινητοποίησης, χειρουργείου, κακοήθειας ή DVT.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Η αξονική πνευμονική αγγειογραφία είναι η στάνταρ εξέταση. Σε εγκύους και σε ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν σκιαγραφικό, η προσέγγιση (σπινθηρογράφημα αιμάτωσης, υπερηχογράφημα Doppler κάτω άκρων) καθορίζεται με τον επιμελητή σας σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος. Αν υπάρχουν σημεία DVT στο πόδι, το υπερηχογράφημα Doppler μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Ποιότητα σκιαγράφησης: υπάρχει επαρκής σκιαγράφηση στον πνευμονικό κορμό;
2. Ξεκινώντας από τις κύριες πνευμονικές αρτηρίες, κατεβείτε διαδοχικά στους λοβιακούς, τμηματικούς και υποτμηματικούς κλάδους και στις δύο πλευρές.
3. Έλλειμμα πλήρωσης: κεντρικό, έκκεντρο, αποφρακτικό.
4. Καταπόνηση της δεξιάς καρδιάς: λόγος δεξιάς κοιλίας / αριστερής κοιλίας, επιπέδωση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, παλινδρόμηση σκιαγραφικού στις ηπατικές φλέβες.
5. Πνευμονικό παράθυρο: έμφρακτο, συλλογή, εναλλακτική διάγνωση.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Σημεία καταπόνησης της δεξιάς κοιλίας · θρόμβος στις κύριες αρτηρίες ή στον διχασμό (εφιππεύων) · μη διαγνωστική εξέταση λόγω ανεπαρκούς σκιαγράφησης

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Σε κάθε εμβολή με σημεία καταπόνησης της δεξιάς καρδιάς και όταν δεν είστε βέβαιοι αν η εξέταση είναι διαγνωστική.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Τεχνική επάρκεια, το πιο κεντρικό επίπεδο και η έκταση της εμβολής, σημεία καταπόνησης της δεξιάς καρδιάς, εναλλακτική διάγνωση, ώρα ενημέρωσης.

Σενάριο 14 ΘΩΡΑΚΑΣ

Διαξιφιστικός θωρακικός πόνος ή πόνος στη ράχη: οξύ αορτικό σύνδρομο

Κλινική εικόνα: Αιφνίδιος, έντονος πόνος που αντανακλά στη ράχη· μπορεί να συνοδεύεται από διαφορά αρτηριακής πίεσης μεταξύ των άνω άκρων, ασυμμετρία σφύξεων, νευρολογικό έλλειμμα ή συγκοπή.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Η αξονική αορτογραφία είναι η εξέταση επιλογής· σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος λαμβάνονται μαζί σειρά χωρίς σκιαγραφικό (για ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα) και αρτηριακή φάση. Σε αιμοδυναμικά ασταθή ασθενή, η κλινική ομάδα μπορεί να εκτιμήσει με υπερηχοκαρδιογράφημα στην κλίνη.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Μηνοειδής υπέρπυκνη πάχυνση του αορτικού τοιχώματος στη σειρά χωρίς σκιαγραφικό (ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα).
2. Ενδοτοιχωματικός κρημνός στην αρτηριακή φάση: ξεκινήστε από την ανιούσα αορτή.
3. Πού αρχίζει και πού τελειώνει ο διαχωρισμός: υπάρχει συμμετοχή της ανιούσας αορτής;
4. Κλάδοι: κλάδοι του αορτικού τόξου, κοιλιακή αρτηρία, SMA, νεφρικές αρτηρίες· από ποιον αυλό τροφοδοτούνται.
5. Περικαρδιακή και πλευριτική συλλογή, μεσοθωρακικό αιμάτωμα.
6. Αιμάτωση οργάνων: έντερο, νεφροί.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Συμμετοχή της ανιούσας αορτής · αιμοπερικάρδιο · σημεία ρήξης · απόφραξη κλάδων και ισχαιμία οργάνων

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Τη στιγμή που βλέπετε οξύ αορτικό σύνδρομο, πριν γράψετε τη γνωμάτευση. Η συμμετοχή της ανιούσας αορτής είναι η πιο επείγουσα κατάσταση.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Σημείο έναρξης και λήξης του διαχωρισμού, συμμετοχή της ανιούσας αορτής (ρητά ναι/όχι), κατάσταση των κλάδων, συλλογές, ισχαιμία οργάνων, ώρα ενημέρωσης.

Σενάριο 15 ΘΩΡΑΚΑΣ

Αιφνίδιος θωρακικός πόνος σε νεαρό ασθενή: αυτόματος πνευμοθώρακας

Κλινική εικόνα: Αιφνίδιος πλευριτικός πόνος και δύσπνοια· συχνά ψηλός, λεπτός νέος καπνιστής ή ασθενής με υποκείμενη πνευμονοπάθεια.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Η οπισθιοπρόσθια ακτινογραφία θώρακα σε όρθια θέση είναι η πρώτη εξέταση. Το υπερηχογράφημα στην κλίνη (ολίσθηση πνεύμονα, γραμμές A, σημείο πνεύμονα) δίνει γρήγορη υποστήριξη. Η αξονική εξετάζεται σε επιπλεγμένα περιστατικά, σε υποκείμενη πνευμονοπάθεια ή αν η ακτινογραφία είναι αμφίβολη.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Εξετάστε τις κορυφές με μεγέθυνση: λεπτή λευκή γραμμή του σπλαχνικού υπεζωκότα.
2. Απουσία πνευμονικής αγγείωσης έξω από τη γραμμή.
3. Οι πλευρές και το χείλος της ωμοπλάτης να μη συγχέονται με τη γραμμή του υπεζωκότα.
4. Θέση του μεσοθωρακίου και της τραχείας.
5. Υποκείμενη πομφόλυγα, μάζα, συλλογή.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Ώθηση του μεσοθωρακίου προς την αντίθετη πλευρά · επιπέδωση του διαφράγματος · αμφοτερόπλευρος πνευμοθώρακας · αιμοπνευμοθώρακας

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Όταν βλέπετε σημείο τάσης, αμφοτερόπλευρη συμμετοχή ή επιπλέον αέρα (πνευμομεσοθωράκιο).

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Πλευρά, έκταση (κορυφαίος / σε όλο το ημιθωράκιο), μετατόπιση του μεσοθωρακίου ναι/όχι, συνοδό εύρημα, ενημέρωση.

Σενάριο 16 ΘΩΡΑΚΑΣ

Αιφνίδιος αποκορεσμός σε ασθενή σε μηχανικό αερισμό

Κλινική εικόνα: Αιφνίδια πτώση του οξυγόνου, αύξηση της πίεσης των αεραγωγών, υπόταση σε ασθενή σε μηχανικό αερισμό στη ΜΕΘ.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Ακτινογραφία θώρακα στην κλίνη· το υπερηχογράφημα στην κλίνη βοηθά στη γρήγορη διάκριση του πνευμοθώρακα. Ο πνευμοθώρακας υπό τάση είναι κλινική διάγνωση: η απεικόνιση δεν πρέπει να καθυστερεί τη θεραπεία.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Άκρο του ενδοτραχειακού σωλήνα: υπάρχει προώθηση σε κύριο βρόγχο (αερισμός ενός πνεύμονα);
2. Πνευμοθώρακας σε ακτινογραφία σε ύπτια θέση: σημείο βαθιάς αύλακας, ευκρινές καρδιακό περίγραμμα, υπερδιαφάνεια στην άνω κοιλία.
3. Μετατόπιση του μεσοθωρακίου.
4. Νεοεμφανιζόμενη ατελεκτασία ή ολική σκίαση (βύσμα βλέννης).
5. Άλλοι σωλήνες και καθετήρες.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Σημεία πνευμοθώρακα υπό τάση · ΕΤΤ σε κύριο βρόγχο · σκίαση ολόκληρου του ημιθωρακίου

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Όταν βλέπετε πνευμοθώρακα ή κακή θέση σωλήνα, πρώτα ενημερώστε αμέσως τον κλινικό ιατρό και μετά ενημερώστε τον επιμελητή σας.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Πνευμοθώρακας ναι/όχι, θέση του άκρου του ΕΤΤ, μετατόπιση του μεσοθωρακίου, νέα σκίαση, ώρα ενημέρωσης και σε ποιον έγινε.

Σενάριο 17 ΘΩΡΑΚΑΣ

Ακτινογραφία ΜΕΘ: έλεγχος σωλήνων και καθετήρων

Κλινική εικόνα: Ακτινογραφία ελέγχου για νεοτοποθετημένο ενδοτραχειακό σωλήνα, κεντρικό φλεβικό καθετήρα, ρινογαστρικό σωλήνα ή σωλήνα θωρακικής παροχέτευσης.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Ακτινογραφία θώρακα στην κλίνη. Για ρινογαστρικό σωλήνα ζητείται, αν χρειάζεται, ακτινογραφία που περιλαμβάνει και την άνω κοιλία. Αν η θέση είναι ασαφής, η επανάληψη της ακτινογραφίας ή επιπλέον προβολή συζητείται με τον κλινικό ιατρό.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Ακολουθήστε κάθε σωλήνα χωριστά από την αρχή ως το τέλος.
2. ΕΤΤ: θέση του άκρου σε σχέση με την τρόπιδα.
3. Κεντρικός φλεβικός καθετήρας: πορεία, θέση του άκρου, υποψία αρτηριακής ή εξωαγγειακής πορείας.
4. Ρινογαστρικός σωλήνας: να κατεβαίνει στη μέση γραμμή κατά μήκος του οισοφάγου, να διασχίζει το διάφραγμα και το άκρο του να βρίσκεται στον στόμαχο· αν έχει εισέλθει σε βρόγχο.
5. Έλεγχος για πνευμοθώρακα μετά από κάθε επέμβαση.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Ρινογαστρικός σωλήνας στο βρογχικό δέντρο · ΕΤΤ σε κύριο βρόγχο ή στον οισοφάγο · πνευμοθώρακας μετά από καθετηριασμό · μη αναμενόμενη πορεία καθετήρα

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Σε ρινογαστρικό σωλήνα που έχει εισέλθει στον αεραγωγό ή σε καθετήρα με υποψία αρτηριακής πορείας· ενημερώστε αμέσως τον κλινικό ιατρό.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Όνομα κάθε συσκευής και ανατομική θέση του άκρου της, τυχόν κακή θέση ρητά, πνευμοθώρακας ναι/όχι, ενημέρωση.

Σενάριο 18 ΘΩΡΑΚΑΣ

Αιμόπτυση

Κλινική εικόνα: Αιμόφυρτα πτύελα ή αίμα από το στόμα· μπορεί να υπάρχει ιστορικό φυματίωσης, βρογχεκτασιών, κακοήθειας. Η μαζική αιμόπτυση απειλεί τη ζωή.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Η ακτινογραφία θώρακα είναι το πρώτο βήμα. Για την πηγή της αιμορραγίας και τον αγγειακό χάρτη ζητείται αξονική θώρακα με σκιαγραφικό ή αξονική αγγειογραφία σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος· αν σχεδιάζεται επεμβατική θεραπεία, είναι σημαντικό να απεικονιστούν οι βρογχικές αρτηρίες.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Πνευμονικό παράθυρο: μάζα, κοιλότητα, βρογχεκτασίες, θολή υάλου (εισρόφηση αίματος).
2. Ευρήματα που καθορίζουν την πλευρά και τον λοβό της αιμορραγίας.
3. Μεσοθωρακικό παράθυρο: διευρυμένες βρογχικές αρτηρίες.
4. Ψευδοανεύρυσμα πνευμονικής αρτηρίας ή αρτηριοφλεβική δυσπλασία.
5. Λεμφαδένες, συλλογή.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Κλινικά μαζική αιμορραγία · αγγειακή δομή εντός κοιλότητας · ψευδοανεύρυσμα · αμφοτερόπλευρη διάχυτη εισρόφηση

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Σε μαζική αιμόπτυση, πριν επιλέξετε το πρωτόκολλο της αξονικής, και όταν βλέπετε εύρημα που μπορεί να απαιτήσει επεμβατική θεραπεία.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Πιθανή πλευρά και πηγή της αιμορραγίας, υποκείμενη βλάβη, κατάσταση των βρογχικών αρτηριών, έκταση της εισρόφησης.

Σενάριο 19 ΘΩΡΑΚΑΣ

Οξεία δύσπνοια: πνευμονικό οίδημα ή πνευμονία;

Κλινική εικόνα: Αιφνίδια δύσπνοια, ορθόπνοια, ρόγχοι σε ηλικιωμένο ασθενή· αν υπάρχει πυρετός και βήχας, και η πνευμονία είναι στη διαφορική διάγνωση.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Η ακτινογραφία θώρακα είναι το πρώτο βήμα. Το υπερηχογράφημα πνευμόνων στην κλίνη (γραμμές Β, συλλογή) υποστηρίζει την κλινική εκτίμηση. Η αξονική δεν είναι το πρώτο βήμα· εξετάζεται όταν τίθεται εναλλακτική διάγνωση (εμβολή, κακοήθεια).

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Μέγεθος καρδιάς και καρδιοθωρακικός δείκτης (σε οπισθιοπρόσθια ακτινογραφία).
2. Ανακατανομή της αιματικής ροής, περιβρογχική περιχαράκωση, γραμμές Kerley B.
3. Περιπυλαίες, αμφοτερόπλευρες συμμετρικές σκιάσεις (υπέρ οιδήματος).
4. Ετερόπλευρη λοβώδης πύκνωση και αεροβρογχόγραμμα (υπέρ πνευμονίας).
5. Πλευριτική συλλογή και πλευροδιαφραγματικές γωνίες.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Διάχυτη αμφοτερόπλευρη σκίαση και σοβαρή υποξία · ετερόπλευρος «λευκός πνεύμονας» · διεύρυνση του μεσοθωρακίου · πνευμοθώρακας

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Αν η ακτινογραφία δεν συμφωνεί με την κλινική εικόνα, αν υπάρχει μη αναμενόμενη μάζα ή διεύρυνση του μεσοθωρακίου.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Μέγεθος καρδιάς, σημεία οιδήματος, θέση της πύκνωσης, συλλογή, σύγκριση με προηγούμενη ακτινογραφία αν υπάρχει.

Σενάριο 20 ΘΩΡΑΚΑΣ

Πυρετός και πνευμονικό διήθημα σε ανοσοκατεσταλμένο ασθενή

Κλινική εικόνα: Ιστορικό χημειοθεραπείας, μεταμόσχευσης, μακροχρόνιας χορήγησης στεροειδών ή HIV· πυρετός, βήχας, υποξία. Η ακτινογραφία μπορεί να είναι φυσιολογική.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Ξεκινά κανείς με ακτινογραφία θώρακα· αν είναι φυσιολογική ή αμφίβολη, η αξονική θώρακα λεπτών τομών έχει αξία. Αν χρειάζεται σκιαγραφικό, καθορίστε το ανάλογα με την ένδειξη μαζί με τον επιμελητή σας.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Περιοχές θολής υάλου και η κατανομή τους.
2. Οζίδια: περιβάλλουσα άλως θολής υάλου, κοιλοποίηση.
3. Πύκνωση και αεροβρογχόγραμμα.
4. Εικόνα «δέντρου σε άνθηση» (tree-in-bud).
5. Συλλογή, λεμφαδένας, περικάρδιο.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Ταχέως επεκτεινόμενη αμφοτερόπλευρη θολή ύαλος · κοιλοποιούμενα οζίδια · πνευμοθώρακας · διάχυτη πύκνωση

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Σε εύρημα που υποδηλώνει ευκαιριακή λοίμωξη και όταν δεν μπορείτε να περιορίσετε τη διαφορική διάγνωση.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Πρότυπο (θολή ύαλος, οζίδιο, πύκνωση), κατανομή, κοιλοποίηση, λίστα διαφορικής διάγνωσης, σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση.

Σενάριο 21 ΘΩΡΑΚΑΣ

Θωρακικός πόνος μετά από έντονο έμετο: διάτρηση οισοφάγου

Κλινική εικόνα: Θωρακικός πόνος μετά από έμετο, ενδοσκόπηση ή ξένο σώμα, υποδόριο εμφύσημα, πυρετός.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Η ακτινογραφία θώρακα μπορεί να δείξει πνευμομεσοθωράκιο, αλλά μπορεί και να είναι φυσιολογική. Η αξονική, με ή χωρίς από του στόματος σκιαγραφικό, επιλέγεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος· καθορίστε το πρωτόκολλο με τον επιμελητή σας.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Ελεύθερος αέρας στο μεσοθωράκιο, γύρω από τον οισοφάγο (πνευμονικό παράθυρο).
2. Υποδόριο εμφύσημα στον τράχηλο και στο θωρακικό τοίχωμα.
3. Πάχυνση του οισοφαγικού τοιχώματος, θόλωση του περιβάλλοντος λιπώδους ιστού.
4. Αν χορηγήθηκε από του στόματος σκιαγραφικό, διαφυγή εκτός του αυλού.
5. Πλευριτική συλλογή και υδροπνευμοθώρακας.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Αέρας και υγρό στο μεσοθωράκιο · διαφυγή σκιαγραφικού · υδροπνευμοθώρακας · μεσοθωρακική συλλογή

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Κατά την επιλογή του πρωτοκόλλου και τη στιγμή που βλέπετε πνευμομεσοθωράκιο.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Θέση και έκταση του ελεύθερου αέρα, διαφυγή σκιαγραφικού ναι/όχι, συλλογή, πλευριτική συλλογή, ενημέρωση.

Σενάριο 22 ΘΩΡΑΚΑΣ

Πυρετός και ετερόπλευρο πλευριτικό υγρό: υποψία εμπυήματος

Κλινική εικόνα: Πυρετός που δεν υποχωρεί παρά τη θεραπεία της πνευμονίας, πλευριτικός πόνος, συλλογή στην ακτινογραφία.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Η ακτινογραφία δείχνει τη συλλογή· το υπερηχογράφημα έχει μεγάλη αξία για να δείξει τη σύσταση του υγρού (διαφραγμάτια, ηχογένεια) και το σημείο παρακέντησης. Η αξονική θώρακα με σκιαγραφικό ξεκαθαρίζει την πάχυνση και την ενίσχυση του υπεζωκότα, το απόστημα πνεύμονα και τη διαφορική διάγνωση.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Έκταση της συλλογής και μετατόπιση του μεσοθωρακίου.
2. Διαφραγμάτια, χωρισμοί, ηχογενές περιεχόμενο στο υπερηχογράφημα.
3. Στην αξονική ενίσχυση και πάχυνση του σπλαχνικού και του τοιχωματικού υπεζωκότα.
4. Αέρας εντός του υγρού.
5. Απόστημα ή πύκνωση στον παρακείμενο πνεύμονα.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Συλλογή που προκαλεί μετατόπιση του μεσοθωρακίου · αέρας εντός του υγρού (μπορεί να υπάρχει βρογχοϋπεζωκοτικό συρίγγιο) · διαφραγμάτια

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Σε συλλογή με διαφραγμάτια ή αέρα, για τον σχεδιασμό παροχέτευσης.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Πλευρά, έκταση, διαφραγμάτια, πάχυνση και ενίσχυση του υπεζωκότα, πνευμονικό εύρημα, κατάλληλο παράθυρο για παροχέτευση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Επείγοντα κοιλίας και πυέλου

Σενάρια 23–36 · Διάτρηση, απόφραξη, ισχαιμία, αγγεία, χοληφόρα, νεφρός, συστροφή.

Σενάριο 23 ΚΟΙΛΙΑ

Αιφνίδιο έντονο κοιλιακό άλγος και μυϊκή σύσπαση: διάτρηση

Κλινική εικόνα: Ιστορικό πεπτικού έλκους, χρήση ΜΣΑΦ, εκκολπωματίτιδα ή πρόσφατη ενδοσκόπηση· σανιδώδης κοιλία.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Η ακτινογραφία θώρακα σε όρθια θέση μπορεί να δείξει ελεύθερο αέρα κάτω από το διάφραγμα, αλλά μια φυσιολογική ακτινογραφία δεν αποκλείει τη διάτρηση. Η αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό είναι η εξέταση επιλογής για να δείξει τη θέση και την αιτία της διάτρησης.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Σαρώστε όλη την κοιλία με πνευμονικό παράθυρο: μπροστά από το ήπαρ, γύρω από τον στρογγύλο σύνδεσμο, μεσεντέριο.
2. Η περιοχή όπου ο ελεύθερος αέρας είναι πιο άφθονος: υποδεικνύει την πηγή.
3. Έλλειμμα τοιχώματος, πάχυνση τοιχώματος, θόλωση του περιβάλλοντος λίπους.
4. Ελεύθερο υγρό και συλλογή.
5. Οπισθοπεριτοναϊκός αέρας (από δωδεκαδάκτυλο, ορθό).

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Διάχυτος ελεύθερος αέρας · κοπρανώδες περιεχόμενο ή διαφυγή από του στόματος σκιαγραφικού · απόστημα · κλινικά σημεία σήψης

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Σε κάθε περίπτωση που βλέπετε ελεύθερο αέρα· ακόμη και σε μικρή ποσότητα αέρα ασαφούς θέσης.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Ελεύθερος αέρας ναι/όχι και θέση του, πιθανή θέση διάτρησης, συλλογή, ελεύθερο υγρό, ώρα ενημέρωσης.

Σενάριο 24 ΚΟΙΛΙΑ

Πόνος στο δεξιό κάτω τεταρτημόριο: οξεία σκωληκοειδίτιδα στον ενήλικα

Κλινική εικόνα: Πόνος που μεταναστεύει από την περιομφαλική περιοχή στο δεξιό κάτω τεταρτημόριο, ανορεξία, πυρετός, ευαισθησία στο σημείο McBurney.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Σε αδύνατους ασθενείς και στους νέους, το υπερηχογράφημα μπορεί να είναι η πρώτη επιλογή. Στον ενήλικα, αν η διάγνωση είναι αβέβαιη ή εξετάζεται επιπλοκή, η αξονική είναι η εξέταση επιλογής. Στην κύηση δείτε το Σενάριο 49.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Βρείτε το τυφλό και από εκεί ακολουθήστε τη σκωληκοειδή απόφυση από τη βάση έως το άκρο της.
2. Διάμετρος, πάχος τοιχώματος και ενίσχυση.
3. Κοπρόλιθος σκωληκοειδούς.
4. Θόλωση του περισκωληκοειδικού λιπώδους ιστού, ελεύθερο υγρό.
5. Διαταραχή της ακεραιότητας του τοιχώματος, εξωαυλικός αέρας, απόστημα.
6. Εναλλακτικές διαγνώσεις: τελικός ειλεός, δεξιό κόλον, ωοθήκη, ουρητήρας.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Σημεία διάτρησης · περισκωληκοειδικό απόστημα · αέρας ή θρόμβωση στην πυλαία φλέβα

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Σε επιπλεγμένη σκωληκοειδίτιδα και σε αμφίβολα περιστατικά όπου δεν μπορείτε να ακολουθήσετε ολόκληρη τη σκωληκοειδή απόφυση.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Η σκωληκοειδής απόφυση απεικονίστηκε/δεν απεικονίστηκε, διάμετρος και τοίχωμα, κοπρόλιθος, διάτρηση και απόστημα ναι/όχι, εναλλακτική διάγνωση.

Σενάριο 25 ΚΟΙΛΙΑ

Έμετος, διάταση, αδυναμία αποβολής αερίων και κοπράνων: απόφραξη λεπτού εντέρου

Κλινική εικόνα: Προηγούμενο χειρουργείο (συμφύσεις), κήλη ή γνωστός όγκος· κωλικοειδής πόνος.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Η απλή ακτινογραφία κοιλίας σε όρθια θέση μπορεί να δείξει διατεταμένες έλικες λεπτού εντέρου και υδραερικά επίπεδα. Η αξονική με σκιαγραφικό είναι η εξέταση επιλογής για να δείξει το σημείο μετάβασης, την αιτία και τις επιπλοκές (στραγγαλισμός, ισχαιμία).

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Διακρίνετε τις διατεταμένες από τις συμπτωματικές έλικες.
2. Βρείτε το σημείο μετάβασης: ακολουθήστε από τη διατεταμένη στη συμπτωματική έλικα.
3. Αιτία: συμφύσεις, κήλη (ελέγξτε όλα τα στόμια κηλών), όγκος, εγκολεασμός εντέρου.
4. Ευρήματα κλειστής έλικας: έλικα σχήματος C ή U, στροβιλισμός στο μεσεντέριο.
5. Ισχαιμία: μειωμένη ενίσχυση του τοιχώματος, οίδημα του τοιχώματος, μεσεντέριο υγρό, πνευμάτωση.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Κλειστή έλικα · σημεία στραγγαλισμού και ισχαιμίας · πνευμάτωση · αέρας στην πυλαία φλέβα

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Σε κλειστή έλικα, εύρημα ισχαιμίας ή όταν δεν μπορείτε να βρείτε το σημείο μετάβασης.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Απόφραξη ναι/όχι, θέση του σημείου μετάβασης, πιθανή αιτία, ευρήματα κλειστής έλικας και ισχαιμίας (ρητά ναι/όχι).

Σενάριο 26 ΚΟΙΛΙΑ

Σημαντική διάταση σε ηλικιωμένο ασθενή: απόφραξη παχέος εντέρου και συστροφή

Κλινική εικόνα: Έντονη διάταση σε κατακεκλιμένο ηλικιωμένο ασθενή με χρόνια δυσκοιλιότητα· αδυναμία αποβολής αερίων και κοπράνων.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Η απλή ακτινογραφία κοιλίας μπορεί να δείξει γιγαντιαία έλικα που υποδηλώνει συστροφή σιγμοειδούς. Η αξονική με σκιαγραφικό επιβεβαιώνει τη διάγνωση και εκτιμά την αιτία (όγκος, συστροφή) και την ισχαιμία.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Ακολουθήστε το κόλον από το ορθό έως το τυφλό.
2. Σημείο μετάβασης και αιτία: μάζα, συστροφή, κοπρόλιθος.
3. Στη συστροφή, στροβιλισμός στο μεσεντέριο και σημείο «ράμφους».
4. Διάμετρος και τοίχωμα του τυφλού.
5. Ανεπάρκεια της ειλεοτυφλικής βαλβίδας (διάταση του λεπτού εντέρου).
6. Πνευμάτωση, ελεύθερος αέρας, μειωμένη ενίσχυση του τοιχώματος.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Σημαντική διάταση του τυφλού · σημεία ισχαιμίας · διάτρηση · συστροφή του τυφλού

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Σε υποψία συστροφής, ισχαιμίας ή διάτρησης.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Επίπεδο της απόφραξης, αιτία, διάμετρος του τυφλού, ισχαιμία και διάτρηση ναι/όχι, ενημέρωση.

Σενάριο 27 ΚΟΙΛΙΑ

Έντονος πόνος δυσανάλογος με την κλινική εξέταση: οξεία μεσεντέρια ισχαιμία

Κλινική εικόνα: Αιφνίδιος έντονος πόνος σε ηλικιωμένο ασθενή με κολπική μαρμαρυγή, αθηροσκλήρωση ή καρδιακή ανεπάρκεια· η κλινική εξέταση είναι σχετικά ήπια.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Η αξονική αγγειογραφία (αρτηριακή και πυλαία φλεβική φάση) είναι η εξέταση επιλογής. Η σειρά χωρίς σκιαγραφικό μπορεί να προστεθεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος για ενδοτοιχωματική αιμορραγία και αποτιτανώσεις. Η απλή ακτινογραφία δεν πρέπει να καθυστερεί τη διάγνωση.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Έκφυση της κοιλιακής αρτηρίας και της SMA, μετά έλλειμμα πλήρωσης κατά μήκος της πορείας τους.
2. SMV και πυλαία φλέβα: φλεβική θρόμβωση.
3. Τοίχωμα του εντέρου: μειωμένη ενίσχυση, λέπτυνση ή πάχυνση.
4. Πνευμάτωση, αέρας στις μεσεντέριες φλέβες και στην πυλαία φλέβα.
5. Έμφρακτα σε άλλα όργανα (σπλήνας, νεφρός): υποδηλώνουν πηγή εμβολής.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Απόφραξη της SMA · πνευμάτωση · αέρας στην πυλαία φλέβα · τμήμα εντέρου χωρίς ενίσχυση

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Τη στιγμή που υποψιάζεστε μεσεντέρια ισχαιμία. Ο χρόνος είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας σε αυτή τη διάγνωση.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Επίπεδο της αρτηριακής ή φλεβικής απόφραξης, προσβεβλημένο τμήμα του εντέρου, σημεία ισχαιμίας, ώρα ενημέρωσης.

Σενάριο 28 ΚΟΙΛΙΑ · ΑΓΓΕΙΑ

Κοιλιακό άλγος ή οσφυαλγία και υπόταση: ρήξη ΑΑΑ

Κλινική εικόνα: Αιφνίδια οσφυαλγία ή κοιλιακό άλγος, συγκοπή, υπόταση σε ηλικιωμένο καπνιστή άνδρα· σφύζουσα μάζα.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Σε αιμοδυναμικά ασταθή ασθενή, το υπερηχογράφημα στην κλίνη μπορεί να δείξει το ανεύρυσμα· η απόφαση ανήκει στην κλινική ομάδα. Σε σταθερό ασθενή η αξονική αγγειογραφία δείχνει τη ρήξη και την ανατομία που απαιτείται για τον σχεδιασμό της θεραπείας.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Μετρήστε τη μεγαλύτερη διάμετρο της αορτής από εξωτερικό τοίχωμα σε εξωτερικό τοίχωμα.
2. Οπισθοπεριτοναϊκό αιμάτωμα: θόλωση του περιαορτικού λίπους και υγρό υψηλής πυκνότητας.
3. Ενεργός διαφυγή σκιαγραφικού.
4. Μηνοειδής υπέρπυκνη περιοχή εντός του θρόμβου (σημείο επικείμενης ρήξης).
5. Σχέση με τις νεφρικές αρτηρίες και λαγόνιες αρτηρίες.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Οπισθοπεριτοναϊκό αιμάτωμα · ενεργός διαφυγή σκιαγραφικού · σημείο μηνίσκου · διαταραχή της συνέχειας του τοιχώματος

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Σε υποψία ρήξης ή επικείμενης ρήξης αμέσως· ενημερώστε ταυτόχρονα και τον κλινικό ιατρό.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Μέγιστη διάμετρος, έκταση, σχέση με τις νεφρικές αρτηρίες, σημεία ρήξης (ρητά ναι/όχι), διαφυγή σκιαγραφικού, ενημέρωση.

Σενάριο 29 ΚΟΙΛΙΑ

Πόνος στο δεξιό άνω τεταρτημόριο και πυρετός: οξεία χολοκυστίτιδα

Κλινική εικόνα: Συνεχής πόνος στο δεξιό άνω τεταρτημόριο που αρχίζει μετά το φαγητό, πυρετός, σημείο Murphy.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Το υπερηχογράφημα είναι η πρώτη εξέταση. Η αξονική έχει αξία σε υποψία επιπλοκής (γάγγραινα, διάτρηση, εμφύσημα) ή αν η διάγνωση είναι αβέβαιη. Σε υποψία χοληδοχολιθίασης μπορεί να σχεδιαστεί MRCP σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Χοληδόχος κύστη: λίθοι, ενσφηνωμένος λίθος στον αυχένα, λάσπη.
2. Πάχυνση τοιχώματος και περιχολοκυστικό υγρό.
3. Υπερηχογραφικό σημείο Murphy με την κεφαλή.
4. Διάμετρος του χοληδόχου πόρου και ενδοηπατικά χοληφόρα.
5. Επιπλοκές: ανωμαλία του τοιχώματος, ενδοαυλικές μεμβράνες, ενδοτοιχωματικός αέρας, διάτρηση.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Εμφυσηματώδης χολοκυστίτιδα · γαγγραινώδης χολοκυστίτιδα · διάτρηση και περιχολοκυστικό απόστημα · διάταση χοληφόρων συμβατή με χολαγγειίτιδα

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Σε εύρημα επιπλοκής, ενδοτοιχωματικό αέρα ή διάταση των χοληφόρων μαζί με πυρετό.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Λίθος, τοίχωμα, περιχολοκυστικό υγρό, σημείο Murphy, διάμετρος χοληφόρων, επιπλοκή ναι/όχι.

Σενάριο 30 ΚΟΙΛΙΑ

Επιγαστρικός πόνος με αντανάκλαση στη ράχη: οξεία παγκρεατίτιδα

Κλινική εικόνα: Πόνος σε ζώνη, έμετος· ιστορικό χολολιθίασης ή αλκοόλ· η διάγνωση συνήθως τίθεται κλινικά και εργαστηριακά.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Αν η διάγνωση έχει τεθεί κλινικά και εργαστηριακά, η αξονική την πρώτη ημέρα δεν είναι πάντα απαραίτητη· για τη χολολιθίαση γίνεται υπερηχογράφημα. Αν η διάγνωση είναι αβέβαιη ή η κλινική εικόνα επιδεινώνεται, ζητείται αξονική με σκιαγραφικό. Για την εκτίμηση των επιπλοκών καθορίστε τον χρόνο της αξονικής με τον επιμελητή σας.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Μέγεθος και περίγραμμα του παγκρέατος, θόλωση του περιπαγκρεατικού λιπώδους ιστού.
2. Περιοχή του παρεγχύματος χωρίς ενίσχυση (νέκρωση).
3. Περιπαγκρεατικές συλλογές υγρού.
4. Αγγειακές επιπλοκές: θρόμβωση σπληνικής φλέβας, ψευδοανεύρυσμα.
5. Χολολιθίαση και χοληδόχος πόρος.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Νέκρωση · αέρας εντός συλλογής · ψευδοανεύρυσμα και αιμορραγία · διάχυτο ελεύθερο υγρό

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Σε υποψία αιμορραγίας, ψευδοανευρύσματος ή επιμολυσμένης νέκρωσης.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Οιδηματώδης ή νεκρωτική εικόνα, συλλογές, αγγειακή επιπλοκή, χολολιθίαση, σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση.

Σενάριο 31 ΚΟΙΛΙΑ · ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Πόνος στο πλάγιο και αιματουρία: νεφρικός κωλικός

Κλινική εικόνα: Κωλικοειδής πόνος στο πλάγιο με αντανάκλαση στη βουβωνική χώρα, ναυτία, αιματουρία.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος επιλέγεται υπερηχογράφημα (υδρονέφρωση) ή αξονική χαμηλής δόσης χωρίς σκιαγραφικό· η αξονική δείχνει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια τον λίθο και τη θέση του. Στους νέους και στις εγκύους προτιμάται το υπερηχογράφημα. Σε ηλικιωμένο ασθενή με εικόνα «νεφρικού κολικού» να έχετε στο μυαλό σας το ΑΑΑ.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Διάταση του αποχετευτικού συστήματος και θόλωση του περινεφρικού λιπώδους ιστού.
2. Ακολουθήστε τον ουρητήρα τομή προς τομή από την πύελο έως την ουροδόχο κύστη.
3. Θέση και μέγεθος του λίθου· μην παραλείψετε την ουρητηροκυστική συμβολή.
4. Διακρίνετε από φλεβόλιθο: ο λίθος βρίσκεται στην πορεία του ουρητήρα και μπορεί να έχει γύρω του δακτύλιο ιστού.
5. Εναλλακτικές διαγνώσεις: σκωληκοειδίτιδα, εκκολπωματίτιδα, ΑΑΑ, ωοθήκη.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Απόφραξη και πυρετός (κίνδυνος ουροσηψαιμίας) · μονήρης νεφρός · αμφοτερόπλευρη απόφραξη · ρήξη θόλου των καλύκων και ούρωμα

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Αν υπάρχει αποφρακτικός λίθος μαζί με εύρημα λοίμωξης ή απόφραξη σε μονήρη νεφρό.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Θέση και μέγεθος του λίθου, βαθμός υδρονέφρωσης, περινεφρικά ευρήματα, εναλλακτική διάγνωση.

Σενάριο 32 ΚΟΙΛΙΑ

Πόνος στο αριστερό κάτω τεταρτημόριο και πυρετός: οξεία εκκολπωματίτιδα

Κλινική εικόνα: Πόνος στο αριστερό κάτω τεταρτημόριο, πυρετός, λευκοκυττάρωση σε ηλικιωμένο ασθενή· μπορεί να υπάρχει γνωστή εκκολπωμάτωση.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Η αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό είναι η εξέταση επιλογής: θέτει τη διάγνωση, δείχνει τις επιπλοκές και κάνει τη διαφορική διάγνωση.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Πάχυνση τοιχώματος στο τμήμα με εκκολπώματα και θόλωση του περικολικού λίπους.
2. Εξωαυλικός αέρας: τοπικός ή ελεύθερος;
3. Απόστημα και μέγεθός του.
4. Συρίγγιο (αέρας εντός της ουροδόχου κύστης).
5. Πάχυνση σε μεγάλο μήκος ή εικόνα «ώμου»: διαφορική διάγνωση από όγκο.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Ελεύθερη διάτρηση · απόστημα · κοπρανώδης περιτονίτιδα · απόφραξη

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Όταν βλέπετε ελεύθερο αέρα ή απόστημα.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Προσβεβλημένο τμήμα, διάκριση επιπλεγμένης / μη επιπλεγμένης, απόστημα και μέγεθός του, ελεύθερος αέρας, σύσταση επανελέγχου αν χρειάζεται διαφορική διάγνωση από όγκο.

Σενάριο 33

ΚΟΙΛΙΑ · ΑΓΓΕΙΑ

Ενεργός αιμορραγία πεπτικού

Κλινική εικόνα: Αιματοχεσία ή μέλαινα, πτώση αιμοσφαιρίνης, αιμοδυναμική αστάθεια· η ενδοσκόπηση μπορεί να μην έχει δείξει την πηγή.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Η πολυφασική αξονική αγγειογραφία (χωρίς σκιαγραφικό, αρτηριακή, πυλαία φλεβική) δείχνει τη θέση της ενεργού αιμορραγίας πριν από επεμβατική θεραπεία ή χειρουργείο. Δεν χορηγείται από του στόματος σκιαγραφικό· εμποδίζει την απεικόνιση της διαφυγής. Επιβεβαιώστε το πρωτόκολλο με τον επιμελητή σας.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Υπέρπυκνο περιεχόμενο στον αυλό στη σειρά χωρίς σκιαγραφικό (πυκνό περιεχόμενο ή υλικό που καταπόθηκε· για σύγκριση με τις επόμενες φάσεις).
2. Νεοεμφανιζόμενο σκιαγραφικό εντός του αυλού στην αρτηριακή φάση.
3. Αύξηση και αλλαγή σχήματος αυτού του σκιαγραφικού στην πυλαία φλεβική φάση.
4. Πηγή της αιμορραγίας: εκκόλπωμα, όγκος, αγγειοδυσπλασία.
5. Τροφοδοτούσα αρτηρία: για την επεμβατική ομάδα.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Ενεργός διαφυγή σκιαγραφικού · υποψία αορτοεντερικού συριγγίου (ιστορικό αορτικού μοσχεύματος) · αιμοδυναμική αστάθεια

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Πριν από το πρωτόκολλο και τη στιγμή που βλέπετε ενεργό διαφυγή σκιαγραφικού· μπορεί να χρειαστεί επεμβατική ακτινολογία.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Ενεργός αιμορραγία ναι/όχι, θέση (τμήμα), πιθανό τροφοδοτούν αγγείο, πιθανή αιτία, ώρα ενημέρωσης.

Σενάριο 34 ΚΟΙΛΙΑ · ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Πυρετός, πόνος στο πλάγιο και σήψη: αποφρακτική πυελονεφρίτιδα

Κλινική εικόνα: Πυρετός, ρίγος, ευαισθησία πλευροσπονδυλικής γωνίας, υπόταση· ιστορικό διαβήτη ή λιθίασης.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Το υπερηχογράφημα δείχνει γρήγορα την απόφραξη. Για επιπλοκές (απόστημα, εμφυσηματώδης πυελονεφρίτιδα) ή αναζήτηση της αιτίας επιλέγεται αξονική, με ή χωρίς σκιαγραφικό, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Υδρονέφρωση και ηχογενές περιεχόμενο στο αποχετευτικό σύστημα (πυονέφρωση).
2. Επίπεδο και αιτία της απόφραξης.
3. Σφηνοειδής περιοχή μειωμένης ενίσχυσης στο παρέγχυμα (αξονική).
4. Νεφρικό ή περινεφρικό απόστημα.
5. Αέρας στο παρέγχυμα ή στο αποχετευτικό σύστημα.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Συνύπαρξη απόφραξης και λοίμωξης · πυονέφρωση · εμφυσηματώδης πυελονεφρίτιδα · απόστημα

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Όταν βλέπετε επιμολυσμένη απόφραξη ή αέρα: μπορεί να χρειαστεί επείγουσα αποσυμπίεση.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Υδρονέφρωση και βαθμός της, αιτία της απόφραξης, αέρας και απόστημα ναι/όχι, ενημέρωση.

Σενάριο 35 ΟΣΧΕΟ

Αιφνίδιος πόνος στο όσχεο: συστροφή όρχεος

Κλινική εικόνα: Αιφνίδιος έντονος πόνος στον όρχι, ναυτία, έμετος σε νεαρό άνδρα· ο όρχις μπορεί να είναι ψηλά και σε οριζόντια θέση.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Έγχρωμο υπερηχογράφημα Doppler. Η συστροφή είναι κλινική διάγνωση: αν η κλινική υποψία είναι υψηλή, η απεικόνιση δεν πρέπει να καθυστερεί το χειρουργείο. Η φυσιολογική ροή στο Doppler δεν αποκλείει πλήρως τη μερική συστροφή.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Πρώτα η ασυμπτωματική πλευρά: ρυθμίστε το Doppler στον φυσιολογικό όρχι.
2. Η ροή στον προσβεβλημένο όρχι με τις ίδιες ρυθμίσεις: μειωμένη ή απούσα.
3. Μέγεθος, ηχογένεια και θέση του όρχεος.
4. Σημείο στροβιλισμού στον σπερματικό τόνο.
5. Διαφορική διάγνωση: επιδιδυμίτιδα (αυξημένη ροή), συστροφή της απόφυσης του όρχεος, τραύμα.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Απουσία ροής ή σαφής ασυμμετρία · συστροφή (σημείο στροβίλου) του σπερματικού τόνου · ανομοιογενής όρχις

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Σε υποψία συστροφής, ταυτόχρονα με τον κλινικό ιατρό, χωρίς να περιμένετε τη γνωμάτευση. Τηλεφωνήστε και όταν το εύρημα είναι αμφίβολο.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Αμφοτερόπλευρη συγκριτική ροή, σημείο στροβιλισμού, ηχογένεια του όρχεος, ότι οι ρυθμίσεις του Doppler διατηρήθηκαν ίδιες, ώρα ενημέρωσης.

Σενάριο 36 ΠΥΕΛΟΣ

Αιφνίδιο πυελικό άλγος και έμετοι: συστροφή ωοθήκης

Κλινική εικόνα: Αιφνίδιο ετερόπλευρο πυελικό άλγος, ναυτία, έμετος σε μη έγκυο γυναίκα· μπορεί να υπάρχει γνωστή κύστη ή μάζα ωοθήκης.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Διακολπικό ή διακοιλιακό υπερηχογράφημα και Doppler. Η παρουσία ροής στο Doppler δεν αποκλείει τη συστροφή· η μορφολογία είναι πιο σημαντική. Πρώτα βεβαιωθείτε ότι το τεστ κύησης είναι γνωστό.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Συγκρίνετε το μέγεθος των ωοθηκών αμφοτερόπλευρα.
2. Διογκωμένη ωοθήκη με περιφερικά διατεταγμένα ωοθυλάκια, οίδημα στρώματος.
3. Μάζα ή κύστη (οδηγό σημείο για τη συστροφή).
4. Σημείο στροβιλισμού στον μίσχο.
5. Ελεύθερο υγρό· διαφορική διάγνωση: ρήξη κύστης, έκτοπη κύηση, σκωληκοειδίτιδα.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Ετερόπλευρα σαφώς διογκωμένη ωοθήκη · σημείο στροβιλισμού · αιμοπεριτόναιο

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Όταν υποψιάζεστε συστροφή και όταν βλέπετε αιμοπεριτόναιο.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Διαστάσεις της ωοθήκης, μορφολογία, μάζα, εύρημα Doppler και οι περιορισμοί του, ελεύθερο υγρό, ενημέρωση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Τραύμα

Σενάρια 37–44 · Πολυτραύμα, κεφαλή, σπονδυλική στήλη, συμπαγή όργανα, πύελος, ουροποιητικό, ισχίο.

Σενάριο 37 ΤΡΑΥΜΑ

Πολυτραύμα υψηλής ενέργειας

Κλινική εικόνα: Τροχαίο ατύχημα, πτώση από ύψος· υποψία κακώσεων σε περισσότερες από μία περιοχές, η αιμοδυναμική κατάσταση ποικίλλει.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Η ομάδα των επειγόντων κάνει eFAST στην κλίνη (ελεύθερο υγρό, πνευμοθώρακας, περικαρδιακό υγρό). Σε σταθερό ασθενή ζητείται αξονική τομογραφία όλου του σώματος (εγκέφαλος, αυχενική μοίρα, θώρακας, κοιλία, πύελος) σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος. Σε ασταθή ασθενή η απόφαση ανήκει στην τραυματολογική ομάδα.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Πρώτα τα απειλητικά για τη ζωή: ενδοκράνια αιμορραγία, πνευμοθώρακας υπό τάση, κάκωση αορτής, ενεργός αιμορραγία.
2. Στη συνέχεια περιοχή-περιοχή με σταθερή σειρά: εγκέφαλος → αυχενική μοίρα → θώρακας → κοιλία → πύελος → σπονδυλική στήλη.
3. Σε κάθε περιοχή ανοίξτε χωριστά το παράθυρο μαλακών μορίων και το οστικό παράθυρο.
4. Θέση σωλήνων και καθετήρων.
5. Τέλος, οι περιφερικές περιοχές: άκρα, οστά του προσώπου.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Ενεργός διαφυγή σκιαγραφικού · κάκωση αορτής · πνευμοθώρακας υπό τάση · ενδοκράνια αιμορραγία και εγκεφαλικός εγκολεασμός · ασταθές κάταγμα σπονδυλικής στήλης

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Όταν δείτε το πρώτο απειλητικό για τη ζωή εύρημα, πριν ολοκληρώσετε όλη την ανάγνωση· κάντε την προκαταρκτική ενημέρωση (πρώτη ανάγνωση) και μετά συνεχίστε με τη λεπτομερή γνωμάτευση.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Τα απειλητικά για τη ζωή ευρήματα στην αρχή της γνωμάτευσης, μετά οι κακώσεις περιοχή-περιοχή· η ώρα της προκαταρκτικής ενημέρωσης και σε ποιον έγινε.

Σενάριο 38 ΤΡΑΥΜΑ · ΝΕΥΡΟ

Κρανιοεγκεφαλική κάκωση: επισκληρίδιο και υποσκληρίδιο αιμάτωμα

Κλινική εικόνα: Πτώση ή χτύπημα· απώλεια συνείδησης, ελεύθερο διάστημα, έμετος, κρίση ή χρήση αντιπηκτικών.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό· με οστικό και εγκεφαλικό παράθυρο. Εκτιμήστε με βάση τα κλινικά κριτήρια αν χρειάζεται και η αυχενική μοίρα.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Εξωαξονική συλλογή: αμφίκυρτη (επισκληρίδια) ή μηνοειδής (υποσκληρίδια).
2. Θλάση: μετωπιαίοι και κροταφικοί πόλοι, περιοχές πλήξης και αντιπλήξης.
3. Τραυματική ΥΑΑ και ενδοκοιλιακό αίμα.
4. Πιεστική επίδραση, εγκεφαλικός εγκολεασμός, βασικές δεξαμενές.
5. Οστικό παράθυρο: θόλος του κρανίου, βάση του κρανίου, κροταφικό οστό, οστά του προσώπου.
6. Πνευμοκεφαλία και παραρρίνιοι κόλποι με υδραερικό επίπεδο.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Επισκληρίδιο αιμάτωμα · υποσκληρίδιο με πιεστική επίδραση · εμπιεστικό κάταγμα · κάταγμα βάσης κρανίου και πνευμοκεφαλία · εγκεφαλικός εγκολεασμός

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Σε οποιαδήποτε ενδοκράνια αιμορραγία, πιεστική επίδραση ή εμπιεστικό κάταγμα.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Τύπος, θέση και πάχος της αιμορραγίας, μετατόπιση της μέσης γραμμής, κατάγματα, πνευμοκεφαλία, ώρα ενημέρωσης.

Σενάριο 39 ΤΡΑΥΜΑ · ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Κάκωση αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης

Κλινική εικόνα: Αυχεναλγία, ευαισθησία, νευρολογικό εύρημα ή τραύμα υψηλού κινδύνου ως προς τον μηχανισμό· ασθενής με αυχενικό κολάρο.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Σε ενήλικα υψηλού κινδύνου, η αξονική αυχενικής μοίρας είναι η εξέταση επιλογής. Σε νευρολογικό έλλειμμα ή υποψία κάκωσης συνδέσμων και νωτιαίου μυελού προστίθεται μαγνητική· καθορίστε τον χρόνο με τον επιμελητή σας και την κλινική ομάδα.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Κρανιοαυχενική συμβολή: ινιακοί κόνδυλοι, C1, οδόντας.
2. Τέσσερις γραμμές στο οβελιαίο επίπεδο: πρόσθια σπονδυλική, οπίσθια σπονδυλική, ακανθοπεταλιαία, ακανθωδών αποφύσεων.
3. Εξετάστε κάθε σπόνδυλο χωριστά: σώμα, αυχένας, πέταλο, αρθρικές αποφύσεις και ακανθώδης απόφυση.
4. Επιβεβαιώστε οπωσδήποτε στην εικόνα την αυχενοθωρακική συμβολή (C7–T1).
5. Προσπονδυλικά μαλακά μόρια, ευθυγράμμιση των αρθρικών αποφύσεων.
6. Πιθανότητα κάκωσης της σπονδυλικής αρτηρίας σε κατάγματα του εγκάρσιου τρήματος.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Διαταραχή ευθυγράμμισης · εξάρθρημα αρθρικών αποφύσεων · κάταγμα οδόντος · κάταγμα εγκάρσιου τρήματος · εύρημα συμβατό με νευρολογικό έλλειμμα

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Σε κάθε κάταγμα και σε κάθε διαταραχή ευθυγράμμισης για την οποία δεν είστε βέβαιοι· η απόφαση για αφαίρεση του κολάρου μπορεί να βασιστεί στη γνωμάτευσή σας.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Επίπεδο και τύπος του κατάγματος, ευθυγράμμιση, κατάσταση των αρθρικών αποφύσεων, σπονδυλικός σωλήνας, συμμετοχή του εγκάρσιου τρήματος, σύσταση μαγνητικής ή αξονικής αγγειογραφίας.

Σενάριο 40 ΤΡΑΥΜΑ · ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Κάταγμα θωρακοοσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης

Κλινική εικόνα: Πτώση από ύψος, τροχαίο ατύχημα· οσφυαλγία ή ραχιαλγία, τραύμα χαμηλής ενέργειας σε ασθενή με οστεοπόρωση.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Αν έχει γίνει αξονική όλου του σώματος, η εκτίμηση γίνεται από τις ανασυνθέσεις της σπονδυλικής στήλης· μπορεί επίσης να υπάρχει ξεχωριστά ζητηθείσα αξονική σπονδυλικής στήλης. Σε νευρολογικό έλλειμμα ή υποψία κάκωσης του οπίσθιου συνδεσμικού συμπλέγματος προστίθεται μαγνητική.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Ευθυγράμμιση και ύψη των σπονδυλικών σωμάτων στην οβελιαία ανασύνθεση.
2. Ώθηση του οπίσθιου τοιχώματος προς τον σπονδυλικό σωλήνα (εκρηκτικό κάταγμα).
3. Οπίσθια στοιχεία: πέταλα, αρθρικές αποφύσεις, διάνοιξη μεταξύ των ακανθωδών αποφύσεων.
4. Αφού βρείτε το πρώτο κάταγμα, αναζητήστε δεύτερο, μη γειτονικό κάταγμα.
5. Παρασπονδυλικό αιμάτωμα, συνοδός κάκωση οργάνων.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Οπισθώθηση του οπίσθιου τοιχώματος · μετατόπιση ή διάσπαση · συμμετοχή των οπίσθιων στοιχείων · κατάγματα σε περισσότερα από ένα επίπεδα

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Σε κάθε εύρημα που υποδηλώνει αστάθεια και σε ασθενή με νευρολογικό έλλειμμα.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Επίπεδο, τύπος κατάγματος, στένωση του σπονδυλικού σωλήνα, οπίσθια στοιχεία, δεύτερο κάταγμα ναι/όχι, σύσταση μαγνητικής.

Σενάριο 41 ΤΡΑΥΜΑ · ΚΟΙΛΙΑ

Αμβλύ κοιλιακό τραύμα: κάκωση σπλήνα και ήπατος

Κλινική εικόνα: Πόνος στο αριστερό ή δεξιό άνω τεταρτημόριο, κατάγματα κατώτερων πλευρών, ελεύθερο υγρό στο eFAST· η αιμοδυναμική κατάσταση ποικίλλει.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Σε σταθερό ασθενή, αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό (αρτηριακή και πυλαία φλεβική φάση σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος). Το eFAST δείχνει το ελεύθερο υγρό, αλλά δεν διαβαθμίζει την κάκωση των οργάνων.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Ελεύθερο υγρό και η πυκνότητά του (αιμοπεριτόναιο)· η θέση του πιο πυκνού θρόμβου υποδεικνύει την πηγή.
2. Ρήξη σπλήνα και ήπατος, υποκαψικό αιμάτωμα.
3. Ενεργός διαφυγή σκιαγραφικού και ψευδοανεύρυσμα στην αρτηριακή φάση.
4. Αύξηση της διαφυγής σκιαγραφικού στην πυλαία φλεβική φάση.
5. Νεφρός, πάγκρεας, έντερο και μεσεντέριο.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Ενεργός διαφυγή σκιαγραφικού · ψευδοανεύρυσμα · αυξανόμενο αιμοπεριτόναιο · συμμετοχή της πύλης

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Όταν βλέπετε ενεργό αιμορραγία ή αγγειακή κάκωση· η απόφαση για επεμβατική θεραπεία πρέπει να ληφθεί γρήγορα.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Όργανο που έχει υποστεί κάκωση και έκταση της κάκωσης, αγγειακό εύρημα, ποσότητα αιμοπεριτοναίου, συνοδές κακώσεις, ενημέρωση.

Σενάριο 42 ΤΡΑΥΜΑ · ΠΥΕΛΟΣ

Κάταγμα πυέλου και υπόταση

Κλινική εικόνα: Τραύμα υψηλής ενέργειας, αστάθεια πυέλου, αιμοδυναμική επιβάρυνση· μπορεί να έχει τοποθετηθεί πυελική ζώνη.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος, προσθιοπίσθια ακτινογραφία λεκάνης και αξονική με σκιαγραφικό. Όταν ερμηνεύετε τις εικόνες με τοποθετημένη πυελική ζώνη, μην ξεχνάτε ότι η ζώνη μπορεί να μειώνει τη διάνοιξη του κατάγματος.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Πυελικός δακτύλιος: αναζητήστε κάταγμα στον πρόσθιο και στον οπίσθιο δακτύλιο (ο δακτύλιος συνήθως δεν σπάει σε ένα μόνο σημείο).
2. Διάνοιξη της ηβικής σύμφυσης και των ιερολαγόνιων αρθρώσεων.
3. Ιερό οστό: αναζητήστε κάταγμα ακολουθώντας τα τρήματα.
4. Κοτύλη.
5. Πυελικό αιμάτωμα και ενεργός διαφυγή σκιαγραφικού.
6. Ουροδόχος κύστη, ουρήθρα, ορθό.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Ενεργός αρτηριακή αιμορραγία · διάνοιξη του δακτυλίου · υποψία κάκωσης ουροδόχου κύστης ή ουρήθρας

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Σε ενεργό πυελική αιμορραγία αμέσως: μπορεί να χρειαστεί επεμβατική ακτινολογία.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Θέση των καταγμάτων, ευρήματα σχετικά με τη σταθερότητα του δακτυλίου, ενεργός αιμορραγία, συνοδά ευρήματα ουροποιητικού και ορθού.

Σενάριο 43 ΤΡΑΥΜΑ · ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Αιματουρία μετά από τραύμα: κάκωση νεφρού και ουροδόχου κύστης

Κλινική εικόνα: Αμβλύ ή διατιτραίνον τραύμα, μακροσκοπική αιματουρία, κάταγμα πυέλου, αδυναμία ούρησης.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Αξονική με σκιαγραφικό· σε υποψία κάκωσης του αποχετευτικού συστήματος προστίθεται καθυστερημένη (απεκκριτική) φάση. Σε υποψία κάκωσης της ουροδόχου κύστης σχεδιάζεται αξονική κυστεογραφία σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος. Σε υποψία κάκωσης της ουρήθρας πρέπει να ενημερωθεί η κλινική ομάδα πριν από την τοποθέτηση καθετήρα.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Ρήξη νεφρού, υποκαψικό και περινεφρικό αιμάτωμα.
2. Νεφρική αρτηρία και φλέβα: νεφρός ή τμήμα χωρίς ενίσχυση.
3. Διαφυγή του σκιαγραφικού εκτός του αποχετευτικού συστήματος στην καθυστερημένη φάση.
4. Τοίχωμα της ουροδόχου κύστης και περικυστικό υγρό.
5. Αν η διαφυγή στην κυστεογραφία είναι ενδοπεριτοναϊκή ή εξωπεριτοναϊκή.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Κάκωση νεφρικού μίσχου · ενεργός διαφυγή σκιαγραφικού · διαφυγή ούρων · ενδοπεριτοναϊκή ρήξη ουροδόχου κύστης

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Όταν αποφασίζετε αν χρειάζεται καθυστερημένη φάση ή κυστεογραφία και σε υποψία κάκωσης του μίσχου.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Βάθος της κάκωσης και συμμετοχή του αποχετευτικού συστήματος, αγγειακό εύρημα, τύπος διαφυγής, συνοδά κατάγματα πυέλου.

Σενάριο 44

ΤΡΑΥΜΑ · ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ

Πόνος στο ισχίο μετά από πτώση σε ηλικιωμένο ασθενή

Κλινική εικόνα: Απλή πτώση, πόνος στο ισχίο, αδυναμία φόρτισης· βράχυνση και έξω στροφή του σκέλους μπορεί να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Προσθιοπίσθια ακτινογραφία λεκάνης και πλάγια ακτινογραφία ισχίου. Αν η ακτινογραφία είναι φυσιολογική αλλά η κλινική υποψία επιμένει, συστήνεται μαγνητική (προτιμάται) ή αξονική για αφανές κάταγμα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Αυχένας μηριαίου: συνέχεια του φλοιού, γωνίωση των δοκιδωτών γραμμών, σκληρυντική ζώνη.
2. Γραμμή Shenton και αμφοτερόπλευρη σύγκριση.
3. Τροχαντήρια περιοχή.
4. Ηβικοί και ισχιακοί κλάδοι, κοτύλη, ιερό οστό.
5. Υποκείμενη λυτική ή βλαστική βλάβη (παθολογικό κάταγμα).

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Παρεκτοπισμένο κάταγμα αυχένα · παθολογικό κάταγμα · φυσιολογική ακτινογραφία παρά την κλινική υποψία

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Σε υποψία παθολογικού κατάγματος και κατά την απόφαση για περαιτέρω απεικόνιση για αφανές κάταγμα.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Κάταγμα ναι/όχι, θέση και παρεκτόπισή του, οστική υφή, πρόταση ότι η ακτινογραφία δεν αποκλείει αφανές κάταγμα και σύσταση περαιτέρω απεικόνισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Παιδιατρική και κύηση

Σενάρια 45–50 · Αποφυγή ακτινοβολίας, προτεραιότητα στο υπερηχογράφημα, ασθενείς που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

Ο βασικός κανόνας αυτής της ενότητας

Στα παιδιά και στις εγκύους προτιμώνται μέθοδοι που δεν απαιτούν ιοντίζουσα ακτινοβολία (υπερηχογράφημα, μαγνητική όταν ενδείκνυται). Ωστόσο, μια πραγματικά αναγκαία εξέταση δεν πρέπει να αναβάλλεται λόγω ανησυχίας για την ακτινοβολία. Όταν διστάζετε, συμβουλευτείτε τον επιμελητή σας.

Σενάριο 45 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Πόνος στο δεξιό κάτω τεταρτημόριο σε παιδί: σκωληκοειδίτιδα

Κλινική εικόνα: Κοιλιακό άλγος, έμετος, πυρετός, ευαισθησία στο δεξιό κάτω τεταρτημόριο· στο μικρό παιδί η εικόνα μπορεί να είναι ασαφής.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Το υπερηχογράφημα είναι η πρώτη εξέταση. Αν η σκωληκοειδής απόφυση δεν απεικονίζεται στο υπερηχογράφημα και η κλινική υποψία επιμένει, η πορεία (παρακολούθηση και επανάληψη υπερηχογραφήματος, μαγνητική ή αξονική) καθορίζεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος με τον επιμελητή σας και την παιδοχειρουργική.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Διαβαθμισμένη συμπίεση με γραμμική κεφαλή: ξεκινήστε από το πιο ευαίσθητο σημείο.
2. Σωληνώδης δομή με τυφλό άκρο, χωρίς περισταλτισμό, που δεν συμπιέζεται.
3. Ηχογένεια του τοιχώματος και του περιβάλλοντος λιπώδους ιστού, ροή στο Doppler.
4. Κοπρόλιθος σκωληκοειδούς, ελεύθερο υγρό, απόστημα.
5. Εναλλακτικές διαγνώσεις: μεσεντέρια λεμφαδενίτιδα, εγκολεασμός εντέρου, παθολογία ωοθήκης.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Διάτρηση και απόστημα · υψηλή κλινική υποψία ενώ η σκωληκοειδής απόφυση δεν απεικονίζεται · εγκολεασμός εντέρου

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Όταν η σκωληκοειδής απόφυση δεν απεικονίζεται και για την απόφαση περαιτέρω απεικόνισης.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Η σκωληκοειδής απόφυση απεικονίστηκε/δεν απεικονίστηκε (ρητά), ευρήματα, επιπλοκή, εναλλακτική διάγνωση, σύσταση.

Σενάριο 46 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Διαλείπων κωλικοειδής πόνος σε μικρό παιδί: εγκολεασμός εντέρου

Κλινική εικόνα: Επεισόδια έντονου κλάματος κατά διαστήματα, ο ασθενής τραβά τα πόδια προς την κοιλιά, έμετοι, λήθαργος· τα κόπρανα τύπου «ζελέ φραγκοστάφυλου» είναι όψιμο εύρημα.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Το υπερηχογράφημα είναι η εξέταση επιλογής για τη διάγνωση. Απλή ακτινογραφία μπορεί να προστεθεί σε υποψία διάτρησης ή απόφραξης. Η απόφαση για ανάταξη και η μέθοδος καθορίζονται σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος από τον επιμελητή σας και την παιδοχειρουργική.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Σαρώστε όλη την πορεία του κόλου ξεκινώντας από το δεξιό κάτω τεταρτημόριο.
2. Στις αξονικές τομές ομόκεντροι δακτύλιοι (εικόνα στόχου), στις επιμήκεις τομές εικόνα ψευδονεφρού.
3. Υγρό και λεμφαδένες εντός του εγκολεασμού.
4. Ροή στο Doppler στο τοίχωμα.
5. Οδηγό σημείο και ελεύθερο υγρό.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Μείωση της αιματικής ροής · ελεύθερος αέρας ή σημεία περιτονίτιδας · οδηγό σημείο (lead point)

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Τη στιγμή που βλέπετε ειλεοκολικό εγκολεασμό· για το σχέδιο ανάταξης.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Τύπος και θέση του εγκολεασμού, ροή στο Doppler, οδηγό σημείο, ελεύθερο υγρό, σημείο διάτρησης, ενημέρωση.

Σενάριο 47 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Κατάποση ή εισρόφηση ξένου σώματος σε παιδί

Κλινική εικόνα: Αιφνίδιος βήχας, κρίση πνιγμού, συριγμός· ή αντικείμενο που είδαν ή υποψιάζονται ότι καταπόθηκε (κέρμα, μπαταρία κομβίου, μαγνήτης).

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Για αντικείμενο που καταπόθηκε, ακτινογραφία που περιλαμβάνει τον τράχηλο και όλο τον γαστρεντερικό σωλήνα. Σε εισρόφηση γίνεται ακτινογραφία θώρακα (ακτινογραφίες σε εκπνοή ή σε κατακεκλιμένη θέση σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος)· μια φυσιολογική ακτινογραφία δεν αποκλείει την εισρόφηση.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Θέση του αντικειμένου: οισοφάγος, στόμαχος, έντερο, αεραγωγός.
2. Διακρίνετε τη μπαταρία κομβίου από το κέρμα: εικόνα διπλού δακτυλίου (halo) στο χείλος της μπαταρίας.
3. Περισσότεροι από ένας μαγνήτες ή μαγνήτης μαζί με μέταλλο.
4. Σε εισρόφηση, ετερόπλευρη παγίδευση αέρα, ατελεκτασία, μετατόπιση του μεσοθωρακίου.
5. Σημεία διάτρησης: ελεύθερος αέρας, πνευμομεσοθωράκιο.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Μπαταρία κομβίου στον οισοφάγο · περισσότεροι από ένας μαγνήτες · ξένο σώμα αεραγωγού · σημείο διάτρησης

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Όταν βλέπετε μπαταρία κομβίου στον οισοφάγο αμέσως· ενημερώστε ταυτόχρονα και τον κλινικό ιατρό. Μην περιμένετε ούτε σε μαγνήτες και ξένα σώματα αεραγωγών.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Θέση και εικόνα του αντικειμένου, αριθμός, πιθανότητα μπαταρίας κομβίου (ρητά), ευρήματα αεραγωγών, διάτρηση ναι/όχι, ώρα ενημέρωσης.

Σενάριο 48 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Κάκωση ασύμβατη με το ιστορικό: υποψία κακοποίησης

Κλινική εικόνα: Κάταγμα που δεν εξηγείται από το ιστορικό που δόθηκε, κακώσεις διαφορετικής ηλικίας, ανεξήγητη ενδοκράνια αιμορραγία· ιδιαίτερα σε μικρά βρέφη.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Εφαρμόζεται το πρωτόκολλο του ιδρύματός σας για την κακοποίηση παιδιών (σκελετικός έλεγχος, αν χρειάζεται αξονική ή μαγνητική εγκεφάλου). Οι αποφάσεις απεικόνισης και η διαδικασία αναφοράς ακολουθούν το πρωτόκολλο και την ομάδα· μην αποφασίζετε μόνοι σας.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Εξετάστε κάθε οστό χωριστά· γωνιακά κατάγματα μεταφύσεων, κατάγματα οπίσθιων πλευρών.
2. Κατάγματα σε διαφορετικά στάδια επούλωσης.
3. Κάταγμα κρανίου και ενδοκράνια αιμορραγία· υποσκληρίδιες συλλογές διαφορετικής πυκνότητας.
4. Κακώσεις κοιλίας.
5. Περιγράψτε τα ευρήματα με αντικειμενικούς και ουδέτερους όρους.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Υποσκληρίδιο αιμάτωμα σε βρέφος · κατάγματα οπίσθιων πλευρών · γωνιακά κατάγματα μεταφύσεων · πολλαπλά κατάγματα διαφορετικής ηλικίας

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Σε κάθε περίπτωση που υποψιάζεστε κακοποίηση, πριν γράψετε τη γνωμάτευση. Αυτές οι γνωματεύσεις μπορεί να έχουν ιατροδικαστικές συνέπειες.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Θέση και εκτιμώμενο στάδιο κάθε ευρήματος (με μη κατηγορηματικές διατυπώσεις), ότι η εκτίμηση της συμφωνίας με το ιστορικό πρέπει να γίνει με την κλινική ομάδα, ενημέρωση.

Σενάριο 49 ΚΥΗΣΗ

Πόνος στο δεξιό κάτω τεταρτημόριο σε έγκυο: υποψία σκωληκοειδίτιδας

Κλινική εικόνα: Κοιλιακό άλγος, ναυτία, πυρετός στην κύηση· λόγω της διογκούμενης μήτρας η σκωληκοειδής απόφυση μπορεί να μετατοπιστεί προς τα πάνω.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Το υπερηχογράφημα είναι η πρώτη εξέταση. Αν το υπερηχογράφημα δεν είναι διαγνωστικό, προτιμάται μαγνητική χωρίς σκιαγραφικό σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ιδρύματος. Αν χρειάζεται αξονική, η απόφαση λαμβάνεται μαζί με τον επιμελητή σας και τη μαιευτική-γυναικολογική ομάδα· μια πραγματικά αναγκαία εξέταση δεν πρέπει να αναβάλλεται.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Αναζητήστε τη σκωληκοειδή απόφυση στη θέση που αναμένεται ανάλογα με την εβδομάδα κύησης.
2. Πάχυνση τοιχώματος, οίδημα του περιβάλλοντος λίπους, ελεύθερο υγρό.
3. Εναλλακτικές διαγνώσεις: συστροφή ωοθήκης, υδρονέφρωση, χολοκυστίτιδα, παθολογίες σχετικές με τον πλακούντα.
4. Αυλός της σκωληκοειδούς απόφυσης και περιβάλλων χώρος στη μαγνητική (ακολουθίες T2 και με καταστολή λίπους).

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Διάτρηση · απόστημα · πιθανότητα μαιευτικού επείγοντος

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Σε έγκυο ασθενή η επιλογή εξέτασης πρέπει πάντα να γίνεται κατόπιν συνεννόησης: τηλεφωνήστε όταν έρθει το παραπεμπτικό.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Εβδομάδα κύησης (αν είναι γνωστή), η σκωληκοειδής απόφυση απεικονίστηκε/δεν απεικονίστηκε, ευρήματα, εναλλακτική διάγνωση, σύσταση.

Σενάριο 50 ΚΥΗΣΗ

Πόνος και αιμορραγία στην πρώιμη κύηση: έκτοπη κύηση

Κλινική εικόνα: Θετικό τεστ κύησης, πυελικό άλγος, κολπική αιμορραγία· η υπόταση υποδηλώνει ρήξη.

ΠΟΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ;

Διακολπικό υπερηχογράφημα (αλλιώς διακοιλιακό). Η εκτίμηση γίνεται μαζί με τη μαιευτική-γυναικολογική ομάδα και με βάση τα εργαστηριακά αποτελέσματα. Σε ασταθή ασθενή αναζητείται γρήγορα ελεύθερο υγρό στον θύλακο του Morison και στην πύελο.

ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1. Υπάρχει σάκος κύησης εντός της μήτρας· περιεχόμενο (λεκιθικός σάκος, έμβρυο).
2. Εξαρτήματα: μάζα ξεχωριστή από την ωοθήκη ή εικόνα δακτυλίου.
3. Ελεύθερο υγρό στον χώρο του Douglas και η ηχογένειά του.
4. Θύλακος του Morison: διάχυτο αιμοπεριτόναιο.
5. Άτυπες εντοπίσεις: διάμεση, τραχηλική, ουλή καισαρικής.

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ

- Ηχογενές ελεύθερο υγρό και αιμοπεριτόναιο · μάζα εξαρτημάτων και κενή μήτρα · υγρό στον θύλακο του Morison

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΑΣ

Σε υποψία αιμοπεριτοναίου ή έκτοπης κύησης· ενημερώστε ταυτόχρονα τον κλινικό ιατρό και τη μαιευτική-γυναικολογική ομάδα.

ΓΡΑΨΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

Ενδομήτρια κύηση απεικονίστηκε/δεν απεικονίστηκε, εύρημα εξαρτημάτων, ποσότητα και χαρακτήρας του ελεύθερου υγρού, ώρα ενημέρωσης. Χρησιμοποιήστε ρητά τη διατύπωση «κύηση άγνωστης εντόπισης» όταν χρειάζεται.

Το κοινό δίδαγμα των 50 σεναρίων

Σε κάθε σενάριο εφαρμόσατε τα ίδια τέσσερα βήματα: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ, ΣΑΡΩΣΤΕ, ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ, ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ. Όταν βλέπετε επείγον εύρημα, πρώτα ενημερώνετε και μετά ολοκληρώνετε τη γνωμάτευση. Γράφετε πάντα την ώρα της ενημέρωσης και σε ποιον έγινε.

Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν αντικαθιστά την εκπαίδευση της ειδικότητας, την εποπτεία, την κλινική κρίση ή τη γνωμάτευση ειδικού.

Επόμενο βήμα

Πλέον ξέρετε τι να κάνετε σε κάθε επείγουσα κλινική εικόνα. Τώρα σειρά έχει να κάνετε σωστά το τηλεφώνημα.

«Πριν Καλέσετε τον Επιμελητή: Προετοιμασία σε 25 Σενάρια» (Μπόνους 1): ανοίξτε το και δείτε βήμα-βήμα τι πρέπει να έχετε έτοιμο πριν τηλεφωνήσετε στον επιμελητή σας και με ποια πρόταση θα ξεκινήσετε τη συνομιλία.